



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

MANAJEMEN KUALITAS DAN PENINGKATAN LAYANAN KEPERAWATAN

Aemilianus Mau
Chandra Apriadi Pandual
Sri Rusmini
Eliza
Novita Verayanti Manalu

Editor: Sri Yulia



BUNGA RAMPAI: MANAJEMEN KUALITAS DAN PENINGKATAN LAYANAN KEPERAWATAN

Penulis:

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Chandra Apriadi Pandual, S.Kep., MNursing.
Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.
Ns. Eliza, S.Pd., S.Kep., M.Kep.
Novita Verayanti Manalu, S.Kp., Ns., MAN.

Editor:

Dr. Sri Yulia, S.Kp., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Manajemen Kualitas dan Peningkatan Layanan Keperawatan

Penulis: Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Chandra Apriadi Pandual, S.Kep., MNursing.

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.

Ns. Eliza, S.Pd., S.Kep., M.Kep.

Novita Verayanti Manalu, S.Kp., Ns., MAN.

Editor: Dr. Sri Yulia, S.Kp., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-11-4

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ***Bunga Rampai: Manajemen Kualitas dan Peningkatan Layanan Keperawatan*** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan mutu layanan keperawatan yang merupakan komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan.

Kualitas layanan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis semata, tetapi juga oleh kemampuan manajerial, integritas profesional, dan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pasien serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk memberikan wawasan dan panduan komprehensif mengenai berbagai aspek penting dalam manajemen mutu keperawatan.

Pada bagian pertama, dibahas mengenai Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi Perawat, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kapasitas secara berkelanjutan sebagai dasar pelayanan yang aman dan berkualitas.

Bab selanjutnya membahas Audit Keperawatan: Proses, Metode, dan Implementasinya, sebagai alat evaluasi dan kontrol mutu layanan yang sistematis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Kemudian, dibahas pula tentang Pengelolaan Risiko dalam Keperawatan untuk Peningkatan Kualitas Layanan, yang menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan praktik yang aman, baik bagi pasien maupun tenaga keperawatan itu sendiri.

Selanjutnya, buku ini mengulas Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keperawatan, yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman serta dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan.

Terakhir, dibahas Manajemen Waktu dalam Keperawatan: Teknik untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan, sebagai keterampilan penting dalam menghadapi beban kerja yang tinggi tanpa mengorbankan mutu pelayanan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, praktisi keperawatan, manajer keperawatan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui optimalisasi peran keperawatan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN BAGI PERAWAT 1

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian pengembangan professional berkelanjutan.....	2
C. Tujuan	4
D. Prinsip PKB Perawat Indonesia	4
E. Bentuk kegiatan PKB Perawat Indonesia	5
F. Jenis pelatihan kekhususan perawat Indonesia	6
G. Bentuk kegiatan pengembangan professional berkelanjutan pemerintah	10
H. Program PKB melalui LMS Kemenkes	12
I. Pemenuhan kebutuhan SKP perawatan melalui kegiatan PKB.....	13
J. Kesimpulan.....	20
K. Daftar Pustaka	20

CHAPTER 2 AUDIT KEPERAWATAN: PROSES, METODE DAN IMPLEMETASINYA23

Ns. Chandra Apriadi Pandual, S.Kep., MNursing.	23
A. Pendahuluan	23
B. Proses Audit Keperawatan.....	25
C. Tim audit Keperawatan: Peran dan Tanggung Jawab	27
D. Standar yang Dipakai dalam Audit Keperawatan.....	28
E. Metode Audit Keperawatan.....	29
F. Penggunaan Teknologi dalam Audit Keperawatan.....	32
G. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Audit Keperawatan	33
H. Penutup	36
I. Referensi	36

CHAPTER 3 PENGELOLAAN RISIKO DALAM KEPERAWATAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN.....39

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.	39
A. Pendahuluan	39
B. Konsep Dasar Pengelolaan Risiko.....	40
C. Pendekatan Dalam Pengelolaan Risiko.....	41

D. Peran Perawat dalam Pengelolaan Risiko	43
E. Kualitas Layanan dalam Keperawatan.....	44
F. Studi Kasus : Pengelolaan Risiko Dalam Praktek.....	46
G. Kesimpulan.....	48
H. Referensi	48
I. Glosarium	49

CHAPTER 4 PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS

LAYANAN KEPERAWATAN 51

Ns. Eliza, S.Pd., S.Kep., M.Kep.	51
A. Pendahuluan	51
B. Kualitas Layanan	52
C. Teknologi Informasi.....	58
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi	58
E. Dampak Teknologi Informasi	59
F. Jenis Teknologi Informasi	60
G. Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keperawatan.....	61
H. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan	64
I. Kesimpulan.....	67
J. Referensi	69
K. Glosarium	71

CHAPTER 5 MANAJEMEN WAKTU DALAM KEPERAWATAN: TEKNIK

UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI LAYANAN 73

Novita Verayanti Manalu, S.Kp., Ns., MAN.....	73
A. Pendahuluan	73
B. Keuntungan Manajemen Waktu dalam Keperawatan.....	74
C. Keterampilan Manajemen Waktu Perawat.....	75
D. Keterampilan Manajemen Waktu Utama untuk Mahasiswa Keperawatan.....	78
E. Panduan Komprehensif Manajemen Waktu yang Efektif.....	79
F. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Manajemen Waktu	81
G. 8 Tips Manajemen Waktu Perawat.....	82
H. Kesimpulan.....	87
I. Referensi	87
J. Glosarium	90

PROFIL PENULIS 91

CHAPTER 1

PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN BAGI PERAWAT

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB/CPD) adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa perawat tetap kompeten, terampil, dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Kegiatan PKB mencakup berbagai aktivitas seperti praktik profesional, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, penelitian, penulisan ilmiah (termasuk publikasi hasil penelitian di jurnal), serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks manajemen kualitas dan peningkatan layanan keperawatan, PKB memegang peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan keperawatan. Program ini tidak hanya relevan bagi perawat sebagai individu profesional, tetapi juga bagi organisasi kesehatan yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pasien (Depkes, 2023).

Continuing Professional Development (CPD) merupakan proses di mana seorang profesional mempertahankan kualitas dan relevansi layanan profesionalnya sepanjang kariernya. Pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan oleh perawat untuk memastikan mereka dapat memberikan perawatan yang konsisten dan berkualitas kepada pasien (Thomas, 2012). Menurut Australian Nursing and Midwifery Council (ANMC, 2009), CPD memberikan kesempatan kepada perawat untuk memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan, keahlian, serta mengembangkan kualitas pribadi dan profesionalitas yang diperlukan. CPD telah ditetapkan sebagai persyaratan formal untuk registrasi ulang Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011. Setiap perawat diwajibkan memiliki minimal 25 Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk memperpanjang STR.

Namun, pelaksanaan CPD sering menghadapi berbagai kendala. Purnamawati (2016) mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan waktu akibat tuntutan jam kerja, kurangnya dukungan dari organisasi, rekan sejawat, atau keluarga, pembiayaan yang terbatas, serta minimnya kesempatan belajar dan pengetahuan tentang CPD. Meskipun CPD menjadi syarat untuk pengurusan Surat Izin Praktik

(SIP), masih banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki program yang mendukung pengembangan profesional dan personal perawat.

Pengembangan profesional berkelanjutan bagi perawat memainkan peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan nasional. PKB berkontribusi pada peningkatan kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, kepuasan kerja perawat, dan efisiensi biaya perawatan kesehatan. Namun, bukti menunjukkan bahwa partisipasi perawat dalam PKB masih rendah, dan program yang ada sering kali tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan nyata mereka (Calatayud, 2021). PKB adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia keperawatan. Kecerdasan buatan (AI), sistem robotik, ketergantungan masyarakat pada ponsel, internet, media sosial, serta meningkatnya penggunaan telehealth dan model perawatan virtual lainnya telah memengaruhi praktik keperawatan secara global (Booth et al., 2021). Dalam konteks ini, Learning Management System (LMS) menjadi alat yang relevan dalam pendidikan keperawatan. LMS memungkinkan pembaruan informasi dan metode pembelajaran secara berkelanjutan. Selama pandemi, media pembelajaran berbasis LMS telah digunakan sebagai alternatif pembelajaran, memberikan akses mudah ke sumber daya, webinar, dan modul e-learning (Hastuti et al., 2021). LMS memfasilitasi pendidikan berkelanjutan, memungkinkan perawat untuk terus memperoleh informasi terbaru tentang kemajuan di bidang kesehatan, praktik berbasis bukti, dan perubahan peraturan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis LMS yang memungkinkan tenaga kesehatan, termasuk perawat, untuk belajar secara daring kapan saja dan di mana saja (Depkes, 2023).

Meskipun program pengembangan profesional berkelanjutan telah difasilitasi oleh pemerintah melalui pembelajaran LMS dan oleh organisasi profesi melalui kegiatan ilmiah secara hybrid (daring dan luring), tingkat partisipasi perawat dalam kegiatan ini masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya PKB/CPD bagi perawat untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan efektif.

B. Pengertian pengembangan professional berkelanjutan

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB), dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Continuing Professional Development (CPD), adalah proses terencana dan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kinerja profesional, tidak hanya bermanfaat bagi individu perawat tetapi juga bagi organisasi tempat

mereka bekerja (Norton, 2008). CPD mencakup berbagai aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Kegiatan CPD meliputi pelatihan formal, lokakarya, seminar, hingga pembelajaran mandiri (American Nurses Association (ANA, 2015).

Menurut Hughes (2005), PKB adalah proses pembelajaran sepanjang hayat yang berfokus pada hasil yang dicapai oleh individu atau kelompok. Sedangkan Vasuthevan dan Viljoen (2003) menyatakan bahwa PKB adalah metode untuk meningkatkan kapasitas diri sepanjang karier profesional seorang perawat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan agar tetap kompeten dalam lingkungan kerja profesional.

Dalam konteks tenaga kesehatan, PKB mencakup berbagai aktivitas pembelajaran yang membantu tenaga kesehatan untuk mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi mereka. Proses ini memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat bekerja secara aman, efektif, dan sesuai dengan lingkup praktiknya. Lingkungan kerja yang dinamis menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi mereka (Norton, 2008).

Arunachallam (2009) menambahkan bahwa kegiatan PKB harus dapat meningkatkan kompetensi perawat, yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) (2022), Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) bagi perawat Indonesia adalah proses pengembangan profesional yang mencakup berbagai kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme perawat sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi:

1. Pengalaman memberikan asuhan keperawatan dalam praktik profesional.
2. Mengikuti kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna mendukung kompetensi dan keahlian.
3. Menulis dan mempublikasikan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas.

Pelaksanaan PKB oleh perawat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang mewajibkan perawat untuk mengembangkan praktik profesinya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB/CPD) dapat disimpulkan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional

tenaga kesehatan, khususnya perawat. Definisi ini menegaskan pentingnya PKB sebagai upaya untuk mempertahankan profesionalisme, menjamin keselamatan pasien, dan memenuhi tuntutan lingkungan kerja yang terus berubah. PKB tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas organisasi kesehatan secara keseluruhan.

C. Tujuan

Secara umum, tujuan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya keperawatan. Selain itu, tujuan ini juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tuntutan profesi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan yang sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, dan kode etik keperawatan Indonesia.

Tujuan khusus dari PKB Perawat Indonesia meliputi:

1. Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional perawat agar sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik keperawatan Indonesia.
2. Menjamin mutu pelayanan keperawatan melalui pengembangan kompetensi profesional yang berkesinambungan.

D. Prinsip PKB Perawat Indonesia

Prinsip Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia:

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Diri

Setiap perawat diwajibkan memiliki rencana pengembangan diri sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu kompetensi. Rencana ini dilakukan melalui pengisian Formulir Evaluasi Diri.

2. Kegiatan Mandiri yang Berbasis Praktik (Self-Directed and Practice-Based)

PKB merupakan aktivitas yang bersifat mandiri, di mana perawat secara proaktif menjalankan praktik keperawatan yang berorientasi pada pengembangan profesional berdasarkan pengalaman di lapangan.

3. Peningkatan Kompetensi untuk Re-Registrasi SIP

Kegiatan PKB bertujuan meningkatkan kompetensi perawat dan menjadi salah satu syarat mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah dalam proses re-registrasi Surat Ijin Praktek (SIP).

4. Motivasi untuk Pelayanan Terbaik dan Pengembangan Karier

PKB mendorong perawat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien, memenuhi kewajiban sesuai standar profesi, meraih kepuasan diri, serta mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan jenjang karier profesionalnya.

E. Bentuk kegiatan PKB Perawat Indonesia

Bentuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia meliputi:

1. Kegiatan Praktik Profesional

Kegiatan ini mencakup pelayanan keperawatan yang terdiri dari:

- a. Pemberian asuhan keperawatan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan atau praktik mandiri.
- b. Pembimbingan praktik mahasiswa di klinik atau masyarakat.
- c. Pengelolaan layanan keperawatan di fasilitas kesehatan, seperti kepala dinas kesehatan, direktur keperawatan, kepala bidang perawatan, komite keperawatan, kepala seksi, supervisor/kepala unit/case manager, kepala ruangan, ketua tim, kepala puskesmas, kepala puskesmas pembantu, koordinator program puskesmas, kepala praktik mandiri perawat, serta pengelola keperawatan lainnya.

2. Kegiatan Ilmiah

Kegiatan ilmiah meliputi:

- a. Seminar atau konferensi.
- b. Workshop atau lokakarya.
- c. Pelatihan.
- d. Kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi PPNI.

3. Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Kegiatan ini melibatkan:

- a. Penelitian yang dipublikasikan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta yang memperoleh hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
- b. Presentasi oral atau poster pada tingkat nasional atau internasional.
- c. Penulisan karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, penerjemahan dan penyuntingan buku, serta kegiatan sebagai reviewer.

4. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup:

- a. Partisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi, seperti tim kegiatan keprofesian perawat, pemberdayaan dan edukasi masyarakat.
- b. Bekerja di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

- c. Menjadi pengurus PPNI atau badan kelengkapan lainnya yang diakui oleh PPNI selama masa jabatan.
- d. Terlibat dalam tim tanggap bencana.
- e. Penugasan dari pemerintah, seperti program Nusantara Sehat.
- f. Menjabat sebagai pimpinan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, atau organisasi keagamaan (misalnya, Walikota, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa, RW, RT).
- g. Menerima penghargaan atau prestasi kerja.



PENINGKATAN KOMPETENSI OLEH PPNI



Gambar 1.1 Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi perawat oleh PPNI

F. Jenis pelatihan kekhususan perawat Indonesia

Berikut adalah jenis-jenis kegiatan pelatihan yang dilakukan PPNI melalui badan kelengkapan PPNI: Ikatan dan Himpunan.

Tabel 1. Jenis-jenis kegiatan pelatihan yang dilakukan PPNI melalui Ikatan-Himpunan

No	Ikatan /Himpunan	Jenis Pelatihan	Nama Pelatihan	Nama Pengakuan	Jml Jam/Lama
1	IPKJI	Basic	Terapi Aktivitas Kelompok	Ahli Kep Dasar II	30 Jam/ Sertifikat berlaku 3 tahun
2	IPKKI	Basic	Pelaksanaan dan Pengelolaan Askep Individu dan Keluarga	Ahli Keperawatan Komunitas	30 Jam/Sertifikat berlaku 3 tahun
3	EPEMI	Basic	Maternitas Tingkat Dasar	Ahli Maternitas	30 Jam/Sertifikat berlaku 3 tahun
4	IPANI	Basic	Stimulasi Tumbuh	Ahli Kep Anak Basar	30 jam/Sertifikat

			Kembang Anak		berlaku 3 tahun
5	INKAVIN	Basic	Pengenalan Keperawatan Kardiovaskuler Dasar	Ahli Keperawatan kardiovaskuler Dasar	50 Jam/Sertifikat berlaku 3 tahun
6	IPDI	Basic	Dialisis Dasar	Ahli Keperawatan Dialis	30 Jam/Sertifikat berlaku 5 tahun
7	HIPGABI	Basic	BTCLS	Ahli Keperawatan kegawadaruratan dasar	30 jam/Sertifikat berlaku 3 tahun
8	INWOCNA	Basic	Perawatan Luka Dasar	Ahli Perawatan Luka Dasar	30 Jam/Sertifikat berlaku 3 tahun
9	HIPKABI	Basic	Perawatan Bedah Dasar	Ahli Perawatan Bedah Dasar	30 Jam/Sertifikat berlaku 4 tahun
10	HIPPII	Basic	IPCN Dasar	Ahli Perawatan IPCN Dasar Level 1	42 jam/Sertifikat berlaku 3 tahun
11	IPKJI	Basic	Terapi Aktivitas Kelompok	Ahli Kep Dasar II	30 Jam/ Sertifikat berlaku 3 tahun
12	IPDI	Dialisis bagi Perawat di Rumah Sakit dan Klinik Khusus Dialisis	IPDI		
		Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) untuk Perawat			
13	HIPPI	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi Tenaga Kesehatan 15di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	HIPPI		
		Pelatihan Tim			

		Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini, dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN) dan Wilayah			
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		Training of Trainers (ToT) Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama (FKTP)			
14	HIPGABI	Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	HIPGABI		
15	INKAVIN	Elektrokardiogram (EKG) bagi Perawat di Rumah Sakit	INKAVIN		
		ACLS bagi Perawat			
		Keperawatan Kardiovaskular Tingkat Dasar (PKKvTD) bagi Perawat di Pelayanan Kesehatan			

16	HIPANI	Keperawatan Anastesi Kardiovaskular bagi Perawat Anastesi di Pelayanan Kesehatan	HIPANI		
		TOT Perawat Anastesi			
17	HIMPONI	Keperawatan Kanker Dasar	HIMPONI		
		Penatalaksanaan Pasien Kanker dengan Kemoterapi bagi Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		Training of Trainer (TOT) Keperawatan Kanker Dasar			
18	HIPENI	Asuhan Keperawatan Pasien Stroke Dasar bagi Perawat di Rumah Sakit	HIPENI		
		Asuhan Keperawatan Stroke Komprehensif bagi Perawat di Rumah Sakit			
19	IPKKI	Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	IPKKI		

Sumber: PPNI (2022)

G. Bentuk kegiatan pengembangan professional berkelanjutan pemerintah

Bentuk kegiatan pengembangan professional berkelanjutan yang dikembangkan oleh pemerintah (Kemenkes, RI) adalah pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan/symposium, workshop/lokakarya, sosialisasi, coaching, mentoring, magang (Kemkes, 2023).

1. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan pendidikan atau instruksi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan tertentu yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Pelatihan ini sering kali berbasis praktik dan keterampilan teknis. Contoh: Pelatihan tentang keterampilan dasar life-saving (BLS) untuk perawat, pelatihan penggunaan alat kesehatan terbaru, atau pelatihan tentang pengelolaan infeksi di rumah sakit.

2. Seminar/Konferensi/Sarasehan/Symposium

Kegiatan ilmiah yang melibatkan diskusi dan pertukaran informasi antara para ahli, praktisi, dan peserta mengenai topik-topik terkini yang relevan dengan perkembangan bidang kesehatan. Kegiatan ini dapat berbentuk seminar (lebih kecil dan fokus), konferensi (lebih besar dan formal), sarasehan (diskusi interaktif), atau symposium (acara ilmiah dengan presentasi penelitian). Contoh: Seminar tentang penanggulangan penyakit menular, konferensi internasional tentang peran perawat dalam kesehatan masyarakat, atau sarasehan tentang peran tenaga kesehatan dalam penanganan bencana.

3. Workshop/Lokakarya

Workshop atau lokakarya adalah kegiatan pelatihan yang lebih interaktif dengan tujuan untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau simulasi. Kegiatan ini lebih fokus pada penerapan keterampilan secara langsung dan diskusi kelompok kecil. Workshop tentang penerapan model perawatan berbasis budaya lokal untuk perawat, lokakarya tentang manajemen stres bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan penyuluhan atau pengenalan mengenai suatu kebijakan, program, atau informasi yang penting untuk dipahami oleh tenaga kesehatan, masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau isu kesehatan. Contoh: Sosialisasi mengenai program vaksinasi nasional kepada perawat atau sosialisasi tentang pedoman terbaru dalam pengelolaan diabetes bagi dokter dan perawat.

5. Coaching

Coaching adalah kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh seorang mentor atau pelatih untuk membantu individu dalam mengembangkan kemampuan atau mencapai tujuan tertentu. Coaching lebih bersifat pribadi dan berbasis pada pencapaian hasil atau pengembangan karier. Contoh: Seorang perawat yang mendapat coaching dari seorang mentor berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen unit perawatan intensif atau coaching untuk pengembangan kepemimpinan dalam tim medis.

6. Mentoring

Mentoring adalah proses pembimbingan atau pendampingan seorang tenaga kesehatan yang lebih berpengalaman kepada yang kurang berpengalaman dengan tujuan membantu dalam pengembangan keterampilan profesional, pengetahuan, dan karier. Contoh: Mentoring untuk perawat baru mengenai prosedur standar operasional rumah sakit atau mentoring dalam pengembangan karier bagi perawat yang ingin mengejar pendidikan spesialis.

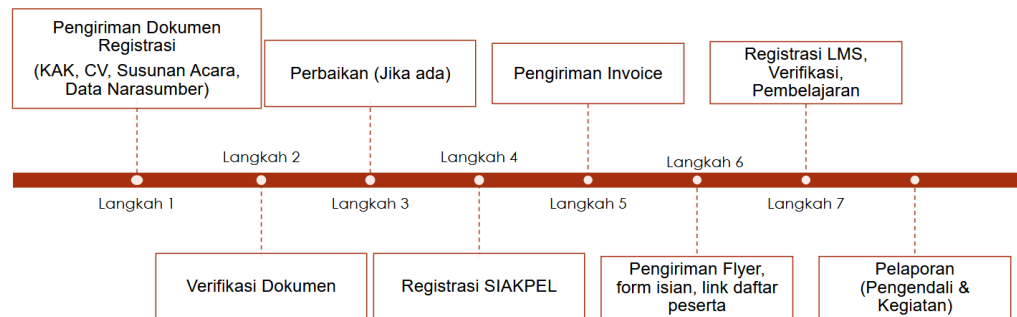
7. Magang

Magang adalah kegiatan praktikum atau pengalaman langsung dalam suatu organisasi atau institusi, di mana tenaga kesehatan memperoleh pengalaman kerja dengan bimbingan dari profesional yang berpengalaman. Magang sering digunakan untuk memperkenalkan peserta pada lingkungan kerja profesional dan meningkatkan keterampilan praktis. Contoh: Magang bagi mahasiswa keperawatan di rumah sakit atau puskesmas untuk mengasah keterampilan klinis mereka, atau magang untuk perawat yang ingin mengembangkan keterampilan manajerial di rumah sakit.

Setiap bentuk kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat, serta menjaga agar mereka tetap terkini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Kegiatan-kegiatan ilmiah di Indonesia harus dilakukan oleh Lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh pemerintah pusat (Ps 258, UU N0.17 th 2023) dan Satuan Kredit Profesi (SKP) dikeluarkan oleh pemerintah (Kemkes) melalui alur pengajuan sebagai berikut:

Alur Pengajuan



Gambar 1.2 Alur pengajuan SKP untuk kegiatan ilmiah (Sosialisasi PPNI, 2024)

H. Program PKB melalui LMS Kemenkes

LMS (Learning Management System) Kemenkes adalah platform pembelajaran online yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk perawat. Berikut adalah alur pembelajaran yang bisa diakses oleh perawat di LMS Kemenkes:

1. Pendaftaran atau Login:

Perawat harus melakukan registrasi di LMS Kemenkes jika belum memiliki akun. Jika sudah terdaftar, perawat dapat langsung login menggunakan username dan password yang telah dibuat.

2. Pemilihan Program Pembelajaran:

Setelah login, perawat dapat memilih program pembelajaran yang tersedia. Program ini dapat berupa pelatihan, kursus, atau modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan topik yang relevan, seperti kompetensi klinis, manajerial, atau keahlian spesifik lainnya.

3. Akses Materi Pembelajaran:

Setelah memilih program, perawat dapat mengakses materi yang disediakan. Materi pembelajaran ini bisa berupa teks, video, modul interaktif, atau slide presentasi. Setiap materi umumnya dipecah menjadi beberapa topik atau sub-topik untuk memudahkan pemahaman.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran:

Perawat dapat mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan waktu yang fleksibel. Beberapa program mungkin melibatkan tugas atau ujian setelah menyelesaikan bagian tertentu dari materi sebagai evaluasi untuk memastikan pemahaman.

5. Tugas dan Ujian:

Pada beberapa pelatihan, terdapat tugas atau ujian yang harus diselesaikan oleh peserta untuk menguji sejauh mana mereka memahami materi. Tugas ini bisa berupa pertanyaan pilihan ganda, esai, atau penugasan berbasis aplikasi.

6. Diskusi atau Forum:

Banyak program pembelajaran menyediakan fasilitas forum atau ruang diskusi untuk berbagi pengalaman atau bertanya tentang materi dengan instruktur atau sesama peserta. Hal ini dapat meningkatkan interaksi dan pembelajaran kolaboratif.

7. Evaluasi dan Sertifikasi:

Setelah menyelesaikan program dan memenuhi semua persyaratan (seperti ujian atau tugas), perawat akan mendapatkan evaluasi atau sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan atau kursus tersebut. Sertifikat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka.

8. Pengembangan Profesional Berkelanjutan:

LMS Kemenkes juga dapat menyediakan akses ke berbagai kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara berkelanjutan.

I. Pemenuhan kebutuhan SKP perawatan melalui kegiatan PKB

Seorang perawat membutuhkan 50 Satuan Kredit Profesi (SKP) selama 5 (lima) tahun sebagai syarat perpanjangan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat melalui kegiatan pembelajaran, pelayanan profesional, dan pengabdian masyarakat. Jumlah SKP yang dikumpulkan perawat melalui kegiatan pembelajaran: materi non kesehatan, kesehatan umum dan spesialis sebesar 25 SKP (50%), dengan ketentuan materi non kesehatan tidak diberikan SKP, materi kesehatan umum diberikan SKP jika Kegiatan dilaksanakan oleh penyelenggara terakreditasi kemenkes dengan peserta lintas profesi, narasumber dari tenaga kesehatan dan melibatkan keperawatan, materi spesifikasi keprofesian diberikan SKP jika Kegiatan dilaksanakan oleh penyelenggara terakreditasi kemenkes dengan peserta lintas profesi. Perhitungan pemberian SKP dari kegiatan pembelajaran:

SKP Pembelajaran



a. SKP Pembelajaran Mandiri / Massive Open Online Courses (MOOC)	1 JEP = 0,5 SKP 2 SKP per kegiatan	1 JEP = 1 SKP 5 SKP per hari	1 JEP = 2 SKP 10 SKP per hari	- Persyaratan pengajuan kegiatan meliputi: a. Narasumber/fasilitator/pelatih/pembicara; b. Surat keterangan lembaga penyelenggara terakreditasi kemkes c. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Susunan acara d. CV Narasumber dan STR Aktif - Pembicara narasumber dari keperawatan dengan kriteria narasumber: ▪ Memiliki STR aktif/seumur hidup ▪ Minimal pendidikan Ners dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun ▪ Daftar riwayat hidup narasumber/fasilitator/instruktur/pembicara Memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang keahlian dan materi yang disampaikan
a. SKP Kegiatan Konferensi/Simposium		1 JEP = 1 SKP Max 8 SKP	1 JEP = 2 SKP Max 16 SKP	
a. SKP Kegiatan Workshop	1 JEP = 1 SKP Max 3 SKP/kegiatan	1 JEP = 1,5 SKP Max 10 SKP/hari	1 JEP = 3 SKP Max 20 SKP/hari	
a. SKP Pembelajaran Mandiri / Massive Open Online Courses (MOOC)	1-30 JEP : 1 SKP >30 JEP : 2 SKP	1-30 JEP : 1 SKP >30 JEP : 2 SKP	1-30 JEP : 1 SKP >30 JEP : 2 SKP	

Gambar 1.3 Pemberian SKP untuk kegiatan pembelajaran (Sosialisasi PPNI, 2024)

SKP untuk kegiatan pelayanan melalui kegiatan praktik keperawatan professional seperti pemeriksaan/diagnosis, melakukan tindakan keperawatan, dan melakukan pemberian pelayanan keprofesional tertentu. Proporsi kegiatan ini sebesar 40% (20 SKP) dikumpulkan selama lima tahun. Rincian kegiatan dan pemberian SKP dapat dilihat pada gambar berikut:

RANAH PELAYANAN/PRAKTIK PROFESIONAL



Kegiatan	Nilai SKP	Unit	Kriteria Pengakuan	Dokumen Pembuktian	Max SKP	Penerapan Pelayanan professional Keperawatan
Pemeriksaan/Diagnosis	DO : Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium sederhana (jika diperlukan) baik melalui pemeriksaan langsung atau telemedisin					- Melakukan skrining/triage/surveillance, - Melakukan Pengkajian, - Menetapkan Diagnosis Keperawatan, - Menetapkan Rencana keperawatan/Perencanaan pulang
	< 25 pasien/bulan: 2 SKP > 25 pasien/bulan: 3 SKP	1. Pasien 2. Spesimen	Kegiatan Rutin	Rekam medis elektronik (RME)/Rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) ttd pimpinan - lembar resmi faskes/institusi	2 SKP	

Ramah pelayanan



Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu	DO : Melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesian.				
1. Tingkat sederhana / Teknologi Sederhana	Per tindakan: 0.5 SKP/ 15 jenis tindakan	1. Pasien 2. Alat kesehatan 3. Tindakan	Melakukan tindakan	Rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) ttd pimpinan - lembar resmi faskes/institusi	5 SKP Melakukan tindakan praktik keperawatan: - Observasi/pemantauan/monitoring kondisi pasien, - Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan dasar/tindakan mandiri, - Melakukan konseling, - Melakukan pelayanan pemulihan Kesehatan, - Melakukan tindakan kolaborasi, - Melakukan pelayanan program nasional, - Melaksanakan asuhan komplementer, - Melaksanakan asuhan paliatif, - Melakukan evaluasi/perkembangan asuhan keperawatan, - Melaksanakan dokumentasi keperawatan/pelaporan program/kegiatan pelayanan

Ramah pelayanan



2. Tingkat menengah / Teknologi Menengah	Per tindakan: 1 SKP/ 10 jenis tindakan			10 SKP	Melakukan tindakan dan praktik asuhan keperawatan di ruang perawatan khusus lanjutan seperti di ICU, IGD, Kamar bedah, dll) dengan pengalaman <5 tahun
3. Tingkat lanjut / Teknologi Tinggi	Pertindakan: 2 SKP/ 5 jenis tindakan			15 SKP	Melakukan tindakan dan praktik asuhan keperawatan di ruang perawatan khusus lanjutan seperti di ICU, IGD, Kamar bedah, dll) dengan pengalaman <5 tahun

Ramah pelayanan



Pemberian pelayanan keprofesian tertentu	DO : Melakukan Assessment, planning, implementasi , dan evaluasi terhadap target unit sesuai keprofesian				
1. Asuhan	<10 kegiatan/ bulan:1 SKP >10 kegiatan/ bulan : 2 SKP	Pasien	Melakukan tindakan	Rekap kegiatan (6 bulan, 1 tahun) ttd pimpinan - lembar resmi faskes/institusi	5 SKP
2. Non Asuhan	<10 kegiatan/ bulan :1 SKP >10 kegiatan/ bulan : 2 SKP	1. Alat Kesehatan 2. Lingkungan 3. Lainnya (sesuai kebutuhan masing-masing kolegium)			

Ramah pelayanan



Melakukan penapisan/ Pemeriksaan Kesehatan (MCU)/ pemeriksaan penunjang lainnya yang mendukung (ditentukan oleh masing-masing kolegium berdasarkan keprofesiannya)	DO : Melakukan pemeriksaan/ screening kesehatan atau pemeriksaan penunjang lain yang mendukung pemeriksaan/ screening kesehatan berdasarkan keprofesiannya				Menjadi perawat khusus di MCU dengan melakukan tindakan pemeriksaan mulai dari assesmen sampai keluar hasil MCU
	1 SKP/ 50 orang	1. Pasien 2. Spesimen	Melakukan tindakan	Rekap kegiatan ttd pimpinan - lembar resmi faskes/institusi	
Membuat Ekspertise di bidang keprofesiannya	DO : Membuat catatan keahlian/keprofesian terkait hasil pemeriksaan tertentu				

Ranah pelayanan



Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal /keterangan- an ahli/saksi ahli/ beracara	5 SKP/kasus	Melakukan kegiatan	Bukti kasus	5 SKP	Melakukan advokasi keperawatan yang ditunjuk langsung oleh organisasi profesi ataupun kolegium yang ditunjukkan dengan surat tugas
--	-------------	--------------------	-------------	-------	--

Ranah pelayanan



Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah/Bencana	DO: Kegiatan kewaspadaan dini dan respon, deteksi dini, penyelidikan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah/bencana				
	5 SKP/Jenis kegiatan	Kegiatan	Melakukan kegiatan	Surat tugas dan laporan kegiatan	5 SKP
Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari pustaka, presentasi(oral/poster), dan mini lecture	Penyaji atau/kasus artikel, atau sari pustaka : 1. Lokal 0,5 SKP 2. Nasional 1,5 SKP 3. Internasional 2 SKP	Jurnal /Artikel	Membuat jurnal/artikel/ presentasi poster/ mini lecture	Bukti artikel/presentasi poster/mini Lecture/sertifikat	5 SKP
	Peserta 0.5 SKP/kasus, artikel, atau sari pustaka		Menjadi peserta artikel	Bukti resume jurnal yang didengar/ dipelajari	
					Menjadi petugas perawat khusus untuk menangani kasus KLB - Jurnal reading dengan pertemuan khusus, - Melaksanakan case report/kasus studi, - Melaksanakan evidence based practice/evidence based manajemen/inovasi berbasis EBP

Ranah pelayanan



Pendidikan lanjut keprofesian dengan gelar	25 SKP/ pendidikan	Mengikuti pendidikan	Keterangan Studi/ Pendidikan	15 SKP	Melanjutkan Pendidikan formal keperawatan - Ners - Magister/Sp1 - Doktor/Sp 2
--	--------------------	----------------------	------------------------------	--------	--

Ramah pelayanan



- Penelitian						
1. Penelitian Utama	5 SKP/ penelitian		Membuat penelitian	Laporan penelitian	5 SKP	- Melakukan Penelitian keperawatan, - Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, - Menulis karya ilmiah (jurnal/artikel) sebagai author atau co-author, - Menulis buku dalam bidang keperawatan/kesehatan, - Menjadi reviewer/editor/pengelola jurnal ilmiah, - Melakukan presentasi oral/poster pada seminar nasional/internasional
2. Peneliti anggota	2 SKP/ Penelitian		Membuat Penelitian	Laporan penelitian	2 SKP	
Publikasi						Melaksanakan penelitian terpublikasi lokal/nasional/internasional
1. Ilmiah	1 SKP / publikasi		Publikasi tulisan	Bukti publikasi	-	
2. Ilmiah Populer	0.5 SKP / publikasi		Publikasi tulisan	Bukti publikasi	-	

Ramah pelayanan



Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajer pelayanan kesehatan	Maksimal 10 SKP/ tahun efektif tugas		Menempati posisi manajerial	SK resmi dari instansi terkait	10 SKP	Disesuaikan dengan manajerial keperawatan di instansi terkait
Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian : Dosen, Pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, penyusun/ reviewer/penguji ujian kompetensi keprofesian, Mitra Bestari, dan Pembimbing klinik	5 SKP / jenis kegiatan		Mengikuti kegiatan	SK resmi dari instansi terkait	5 SKP	Komite keperawatan, mitra bestari

Gambar 1.4 Pemberian SKP untuk ranah pelayanan (Sosialisasi PPNI, 2024)

Ranah pengabdian masyarakat 10% (5 SKP). Berikut cara penilaiannya:

RANAH PENGABDIAN MASYARAKAT



Kegiatan	Level	Pembuktian	Nilai SKP	Deskripsi Kegiatan
Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat	> Lokal (kel - kec – kab) > Provinsi - Nasional	Keterangan/ Sertifikat kegiatan (dari institusi terkait)	> Lokal : 10 SKP > ProvNas : 15 SKP	
Penyuluhan Kesehatan/ Edukasi Medis keprofesian/ Penyuluhan Kedokteran untuk kepentingan hukum	Lembaga atau Komunitas, peserta minimal 20 orang	Surat tugas ataupun sertifikat yang di tandatangani pihak berwenang	3 SKP/ kegiatan	Melakukan kegiatan penyuluhan /social Masyarakat baik dalam tugas institusi ataupun kegiatan dari organisasi profesi/kolegium dan kegiatan kemasyarakatan
Penugasan (Khusus) Pemerintah	Nasional	SK Pemerintah/ Sertifikat	15 SKP / penugasan (maksimal 2 tahun penugasan)	Penugasan khusus perawat
Keterlibatan dalam tim khusus (relawan bencana, tim haji, dll)	Pemda, Pemprov, Pusat	SK Pemerintah/ Sertifikat/ surat tugas yang dikeluarkan oleh Lembaga tertentu atas dasar relawan bencana	10 SKP	Melakukan penanggulangan bencana yang resmi ditugaskan ataupun ada surat keterangan bahwa terlibat dalam penanggulangan bencana

Ranah pengabdian masyarakat



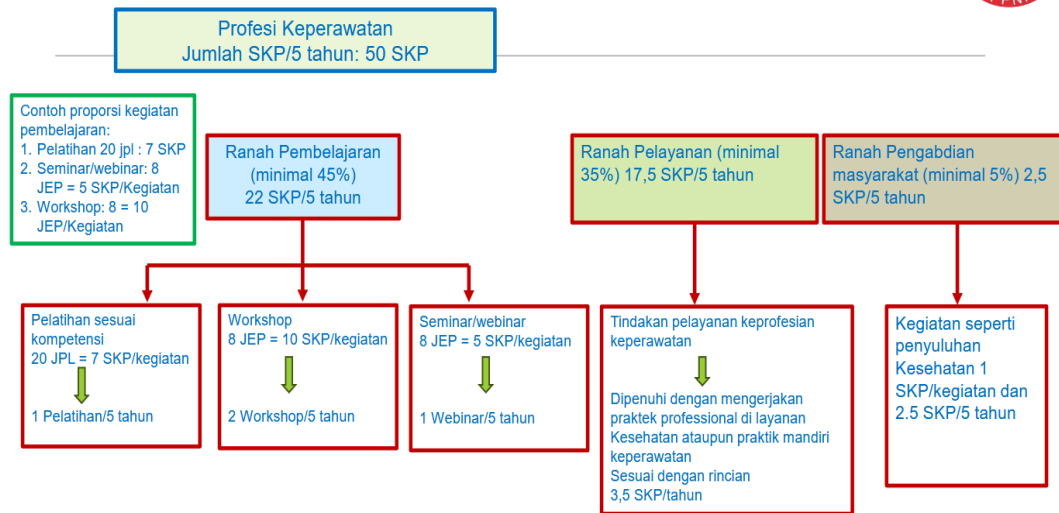
Terlibat dalam Organisasi Keilmuan atau Organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan.	Keprofesian, Lembaga, Pemerintahan	SK resmi dari organisasi terkait	2 SKP/ pengangkatan	Terlibat dalam kepengurusan yang dihitung SKP per periode kepengurusan
Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	Bukti materi melalui media sosial yang dilaksanakan oleh organisasi profesi/ instansi Bukti pengunggahan penyuluhan di media sosial	0.5 SKP/kegiatan (maksimal SKP 3 SKP/ 5 tahun)	Kegiatan resmi yang dilaporkan melalui kolegium atau organisasi keilmuan keperawatn.
Nara sumber rubrik kesehatan/wawancara/edukasi di TV/media massa lain sesuai dengan keprofesian	Lokal/nasional	Surat keterangan dari TV/media massa	1 SKP/kegiatan (maksimal 3 SKP/5 tahun)	Kegiatan yang dilakukan resmi ada undangan khusus dari TV atau media masa.

Gambar 1.5 Pemberian SKP untuk ranah pengabmas (Sosialisasi PPNI, 2024)

Profesi Keperawatan pada kondisi umum wajib mencapai target 50 (lima puluh) SKP dalam periode 5 (lima) tahun dengan persentase pemenuhan dari 3 (tiga) ranah sebagai berikut:

1. Ranah pembelajaran minimal 45 (empat puluh lima) persen atau 22 dua puluh dua koma lima) SKP;
2. Ranah pelayanan minimal 35 (tiga puluh lima) persen atau 17,5 (Tujuhbelas koma lima) SKP;
3. Ranah pengabdian minimal 5 (lima) persen atau 2,5 (dua koma lima) SKP;
4. Sisa persentase dapat dipenuhi dari 3 (tiga) ranah manapun.

SIMULASI PEMENUHAN SKP



Gambar 1.6 Skema pemenuhan SKP (Sosialisasi PPNI, 2024)

J. Kesimpulan

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PKB/CPD) bagi perawat merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan kualitas layanan keperawatan yang terus berkembang. PKB tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu perawat, tetapi juga untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Meskipun program PKB sudah difasilitasi oleh pemerintah dan organisasi profesi melalui berbagai kegiatan, tingkat partisipasi perawat dalam program ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan waktu, dukungan yang minim dari organisasi, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya PKB. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi perawat dalam PKB, termasuk memanfaatkan teknologi dan sistem pembelajaran berbasis digital seperti Learning Management System (LMS), yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi tenaga kesehatan. PKB yang dilakukan dengan baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta profesionalisme perawat.

K. Daftar Pustaka

American Nurses Association. (2015). *Scope and Standards of Practice*. ANA. Joint Commission International. (2018). *Standards for Hospitals*. JCI.

- Arunachallam (2009). The development a model for continuing professional development for professional nurses in South Afrika. PhD: Thesis Univercity of the Western Cape
- Booth R G, Strudwick G, McBride S, Oâ€™Connor S, Solano LÃ³pez A L. How the nursing profession should adapt for a digital future BMJ 2021; 373 :n1190 doi:10.1136/bmj.n1190.
- Catalayud,MV.,dkk. Nurses’ continuing professional development: A systematic literature review. (2021). Nurse Education in Practice, 50, 102963. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102963>.
- Hastuti, D., Andriani, R., & Rosita, E. (2022). Pengembangan media pembelajaran praktik klinik keperawatan medical bedah berbasis learning management system (LMS) selama pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing), 8(1), 131-141. <https://doi.org/10.33023/jikep.v8i1.940>.
- Kementerian Kesehatan RI (2023). Pedoman Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Lainnya Bidang Kesahatan. Jakarta : Dirjen Nakes Kemkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). Sage Publications.
- Norton, M.S. (2008). Human Resourve Administration For Educational Leaders. London: Sage Publication
- PPNI (2022). Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia. Jakarta : DPP PPNI
- Thomas, S. (2012) The implications Of Mandatory Professional Development In Australia. Br J Midwifery
- Vasuthevan, S. & Viljoen, M. (2003). Educational for better health. A handbook to health care profesionals. Cape Town : Juta
- Wong, C. A., Cummings, G. G., & Ducharme, L. (2013). The relationship between nursing leadership and patient outcomes: A systematic review update. *Journal of Nursing Management*, 21(5), 709-724. <https://doi.org/10.1111/jonm.12116>

CHAPTER 2

AUDIT KEPERAWATAN: PROSES, METODE DAN IMPLEMETASINYA

Ns. Chandra Apriadi Pandual, S.Kep., MNursing.

A. Pendahuluan

Audit keperawatan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menilai dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Proses ini merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan keperawatan seperti kepatuhan terhadap standar prosedur keperawatan, bagaimana pelayanan keperawatan diselenggarakan dan bagaimana hasil pelayanan keperawatan dicapai (Masamah, Fransiska, Safenti, & Rianjani, 2023). Audit keperawatan juga dapat dipahami sebagai upaya refleksi untuk mengukur apakah apa yang kaji, direncanakan, dilakukan, dan dicapai dalam pelayanan keperawatan sudah sesuai dengan standar pelayanan keperawatan yang telah ditetapkan (Michl, Bail, Turner, & Paterson, 2024). Dengan kata lain, audit ini adalah cara bagi para perawat untuk mengevaluasi kinerja mereka, menemukan kesenjangan atau masalah yang ada, dan mencari solusi agar mutu pelayanan keperawatan terus meningkat (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2017; Masamah et al., 2023; Michl et al., 2024).

Audit keperawatan memegang peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan standar profesional dan kebutuhan pasien (Senna, Martins, Kammers, Amante, & Sell, 2017). Tujuan utama audit keperawatan adalah menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga berdampak langsung pada keselamatan dan kepuasan pasien. Dalam praktik sehari-hari, audit keperawatan menilai struktur, proses dan hasil sehingga audit keperawatan membantu mengidentifikasi asuhan keperawatan yang ditetapkan di rumah sakit sudah diterapkan sesuai dengan standar atau belum (McCullough et al., 2023; Michl et al., 2024). Audit keperawatan juga memberikan kesempatan kepada tim untuk menemukan pemborosan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan seperti penggunaan sumber daya berlebihan, cara kerja maupun dampak pelayanan terhadap pasien (Iula et al., 2020). Selain itu, audit keperawatan memberikan ruang untuk evaluasi dan refleksi, yang menjadi dasar untuk merancang perbaikan berkelanjutan (Iula et al., 2020; Masamah et al., 2023). Misalnya, jika ditemukan bahwa dokumentasi keperawatan sering kali tidak lengkap, hasil audit dapat digunakan untuk memberikan pelatihan tambahan atau

menyusun sistem pendokumentasian yang lebih efisien. Lebih jauh, audit keperawatan juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas (Christina, Baldwin, Biron, Emed, & Lepage, 2016; Iula et al., 2020). Dengan adanya audit, pelayanan keperawatan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada manajemen rumah sakit maupun kepada pasien dan keluarganya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga reputasi fasilitas kesehatan. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin kompleks, audit keperawatan juga mendukung adaptasi terhadap perubahan (Christina et al., 2016; Effendi, 2018). Dengan memanfaatkan hasil audit, rumah sakit dapat menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, memastikan bahwa standar pelayanan tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terbaru (Hut-Mossel, Ahaus, Welker, & Gans, 2021). Dengan kata lain, audit keperawatan bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga pendorong utama dalam upaya menciptakan pelayanan keperawatan yang lebih baik, lebih aman, lebih moderen dan lebih humanis.

Audit keperawatan memiliki akar sejarah yang secara langsung berhubungan erat dengan perkembangan profesi keperawatan itu sendiri. Praktek pelaksanaan audit keperawatan dilaksanakan sejak dikenalnya kebutuhan akan standar pelayanan keperawatan menjadi perhatian serius terutama setelah revolusi praktek keperawatan abat ke 19 (Gomez, 2017). Florence Nightingale, ibu keperawatan menjadi tokoh penting dalam menelurkan konsep audit keperawatan untuk meningkatkan mutu perawatan pasien (Gomez, 2017). Ide-idenya tentang pentingnya pencatatan, analisa data dan pelaporan dalam pelayanan keperawatan pasien menjadi dasar bagi audit keperawatan moderen (Gomez, 2017).

Awal abad ke 20, secara formal mulai diakui sebagai bagian dari proses peningkatan mutu di rumah sakit. JCAHO Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations mulai mendorong evaluasi secara sistematis terhadap pelayanan keperawatan dan dari sini audit keperawatan berkembang dengan fokus pada tiga aspek utama audit yaitu struktur, proses dan hasil.

Audit keperawatan di Indonesia berkembang sejalan dengan peningkatan tuntutan mutu pelayanan keperawatan. Pada era 1990-an saat akreditasi rumah sakit mulai diterapkan secara luas, audit keperawatan menjadi bagian integral dalam standar akreditasi rumah sakit (Effendi, 2018). Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan keperawatan yang diselenggarakan di rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku (Effendi, 2018; Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2017).

Perkembangan teknologi informasi saat ini juga mendorong transformasi dalam pelaksanaan audit keperawatan. Sistem pencatatan secara elektronik dan

analisa data secara digital memberikan kemungkinan untuk melaksanakan audit keperawatan secara efisien dan akurat menggunakan alat bantu berbasis teknologi termasuk dalam proses analisis tren, pemantauan indikator yang pada akhirnya memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif (De Groot, Triemstra, Paans, & Francke, 2019).

Audit keperawatan telah bertransformasi dari alat evaluasi menjadi bagian integral dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi perawat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Perkembangan ini juga memberikan gambaran bagaimana audit keperawatan tetap menjadi hal yang relevan dalam menjawab tantangan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan kedepannya.

B. Proses Audit Keperawatan

Secara umum audit keperawatan terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap persiapan audit keperawatan, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit keperawatan. Tahap persiapan adalah dasar dari proses audit keperawatan secara keseluruhan dimana pada tahap ini dirancang persiapan untuk melakukan audit keperawatan. Pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan tujuan audit keperawatan dilakukan. Penentuan tujuan sangat penting karena tujuan adalah arah dan fokus dari pelaksanaan audit keperawatan. Pada langkah ini ini ditetapkan apakah tujuan audit adalah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan keperawatan yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan sistem, meningkatkan kinerja tim keperawatan atau hal lainnya. Langkah berikutnya yang penting pada tahap persiapan adalah membentuk tim audit keperawatan. Tim ini harus terdiri dari perawat yang kompeten yang mempunyai pemahaman terhadap standar keperawatan yang berlaku. Tim ini akan menyusun rencana kerja, termasuk jadwal, area yang diaudit metode pengumpulan data serta menyusun pelaporan audit keperawatan yang dilaksanakan. Selain penentuan tujuan dan pembentukan tim, instrumen audit keperawatan juga harus dipersiapkan. Instrumen ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data secara terstruktur dan sistematis. Contoh instrumen yang umum digunakan meliputi daftar pemeriksaan (checklist), lembar observasi, atau panduan wawancara (De Groot et al., 2019). Instrumen ini harus dirancang sesuai dengan standar yang digunakan, sehingga dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan akurat. Persiapan audit keperawatan juga mencakup penetapan standar atau indikator mutu yang digunakan sebagai acuan. Standar yang digunakan dapat berupa kebijakan pelayanan keperawatan, pedoman pelayanan keperawatan, panduan pelayanan keperawatan, alur

pelayanan keperawatan maupun standar prosedur pelayanan keperawatan. Penting untuk diingat bahwa pada tahap ini, komunikasi dengan staf pelayanan keperawatan merupakan kunci pada tahap persiapan audit keperawatan. Semua stakeholder terkait harus memahami tujuan dan pentingnya audit keperawatan yang dilaksanakan, sehingga mereka dapat mendukung proses ini secara aktif.

Tahap pelaksanaan adalah inti dari proses audit keperawatan. Pada tahap ini tim auditor yang dibentuk mulai melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai metode seperti pengisian checklist pada observasi langsung, wawancara dengan perawat, peninjauan dokumentasi keperawatan. Proses pengumpulan data ini harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan pada tahap persiapan. Tim audit keperawatan harus mencatat semua temuan dengan seksama baik itu berupa kepatuhan yang sesuai dengan standar yang berlaku maupun kesenjangannya dan pada tahap ini sangat penting untuk menjaga suasana agar tetap kondusif sehingga staf tidak merasa tertekan dan dengan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan tim audit keperawatan (Sinuff, Muscedere, Rozmovits, Dale, & Scales, 2015). Setelah data hasil audit terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, masalah, atau penyebab dari kesenjangan yang ditemukan. Hasil analisis akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan.

Tahap tindak lanjut adalah langkah terakhir sekaligus yang paling penting untuk memastikan bahwa hasil audit keperawatan yang dilakukan benar-benar bermanfaat. Tim auditor akan menyusun laporan yang mencakup temuan utama, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak manajemen rumah sakit dan stakeholder keperawatan terkait. Rekomendasi yang diberikan harus bersifat anonim (No Name) Tidak menyalahkan (No blaming), tidak untuk memperlakukan (No Shame) dan rekomendasi yang diberikan harus kongkrit, mampulaksana serta berfokus kepada masalah yang ditemukan (Michl, Paterson, & Bail, 2023). Contohnya, jika temuan audit keperawatan yang dilakukan adalah kurangnya pemahaman staf terhadap prosedur keperawatan tertentu maka tindak lanjutnya dapat berupa pelatihan tambahan kepada tenaga keperawatan atau revisi pedoman kerja atau standar prosedur yang berlaku. Selain itu, penting untuk memantau pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan melalui audit lanjutan atau menggunakan mekanisme evaluasi lainnya sehingga audit keperawatan yang dilakukan tidak saja berfungsi sebagai proses untuk mengevaluasi pelayanan keperawatan tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong terjadinya peningkatan mutu keperawatan secara berkelanjutan.

C. Tim audit Keperawatan: Peran dan Tanggung Jawab

Tim audit keperawatan mempunyai peranan penting untuk memastikan proses audit keperawatan berjalan pada koridor waktu yang ditentukan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Tim ini dibentuk dapat menggunakan surat keputusan ataupun surat tugas yang berasal dari pimpinan rumah sakit sesuai dengan regulasi yang berlaku pada rumah sakit tersebut. Sebagai pelaksana audit keperawatan tim audit mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap audit yang dilakukan mulai dari persiapan sampai evaluasi tindak lanjut. Peran dan tanggung jawab tim audit keperawatan diantaranya adalah melakukan desain proses audit keperawatan. Tim audit keperawatan mempunyai tanggung jawab untuk menyusun rencana kerja audit keperawatan secara sistematis. Tim ini menentukan tujuan audit secara operasional, menetapkan ruang lingkup audit keperawatan yang dilakukan, penyusunan jadwal audit keperawatan, dan menetapkan metode yang akan digunakan dalam audit. Selain itu, tim juga perlu menyiapkan instrumen audit, seperti daftar Periksa dan panduan wawancara, yang sesuai dengan standar pelayanan keperawatan yang berlaku. Kemudian tim audit mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisa data.

Pada tahap pelaksanaan tim auditor memiliki peran utama untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan data lainnya yang relevan secara akurat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan perawat, peninjauan dokumen dan catatan lain yang terkait pelayanan keperawatan sesuai dengan yang tertera pada instrumen audit yang dirancang sebelumnya. Pada saat melakukan audit perlu diperhatikan agar auditor wajib bersikap objektif dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang memberikan cerminan kondisi nyata di lapangan. Setelah data yang dibutuhkan telah dikumpulkan maka tanggung jawab berikutnya adalah melakukan analisa data yang dilakukan secara komprehensif. Tim auditor harus dapat mengidentifikasi pola, masalah, kesenjangan antara standar dan kondisi lapangan serta mengidentifikasi penyebab mengapa hal itu terjadi. Analisa yang tepat menjadi dasar untuk mengeluarkan rekomendasi yang efektif kepada stakeholder yang berkepentingan.

Peran penting lainnya dari tim auditor adalah memberikan umpan balik kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses audit termasuk staf keperawatan dan manajemen rumah sakit. Umpan balik ini harus diberikan secara jelas dan konstruktif berdasarkan data valid yang telah dikumpulkan untuk membantu seluruh stakeholder terkait memahami temuan audit dan pengambilan

langkah-langkah perbaikan (Christina et al., 2016; Hut-Mossel et al., 2021). Selanjutnya, Tim auditor juga mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan laporan audit yang mencakup, proses persiapan audit, pelaksanaan audit dan rekomendasi perbaikan dimana laporan ini harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga menjadi dasar untuk pengambilan langkah tindak lanjut oleh pimpinan baik itu pimpinan keperawatan maupun pimpinan rumah sakit.

Peran tim auditor tidak serta merta berhenti setelah laporan diserahkan. Tim ini mempunyai tanggung jawab untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan tersebut. Hal ini mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan benar-benar dilaksanakan sehingga membawa dampak positif dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Selain melakukan evaluasi, tim auditor juga berperan sebagai agen perubahan. Dengan memberikan rekomendasi yang tepat dan mendorong implementasi perbaikan, tim berkontribusi langsung pada peningkatan mutu layanan keperawatan. Secara keseluruhan, tim auditor memegang peran kunci dalam memastikan bahwa audit keperawatan tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menciptakan pelayanan keperawatan yang lebih baik dan lebih aman bagi pasien. Dalam menjalankan seluruh perannya tim auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit dilakukan dan dalam melaksanakan tugas tersebut harus tim auditor harus memegang teguh prinsip etika seperti, adil, objektif dan berintegritas. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dari seluruh pihak yang terlibat.

D. Standar yang Dipakai dalam Audit Keperawatan

Standar keperawatan merupakan acuan utama yang dipakai dalam proses audit keperawatan. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan keperawatan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan (De Groot et al., 2019). Dengan menggunakan standar keperawatan terpercaya yang relevan maka audit keperawatan dapat dilaksanakan secara cermat dan menghasilkan rekomendasi yang objektif. Sumber keperawatan yang dapat digunakan adalah sumber standar keperawatan. Sumber standar keperawatan ini dapat berasal dari sumber diantaranya adalah: Standar Praktik Keperawatan Nasional. Di Indonesia, standar ini biasanya ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), yang mengacu pada prinsip-prinsip keperawatan yang berlaku secara nasional; Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan menyediakan pedoman yang mencakup standar pelayanan keperawatan sebagai

bagian dari evaluasi mutu rumah sakit; Kebijakan Internal Rumah Sakit. Setiap rumah sakit memiliki kebijakan, pedoman, panduan, alur atau standar prosedur operasional yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik fasilitas kesehatan tersebut; Sasaran Keselamatan Pasien: Standar ini dirumuskan untuk memastikan keselamatan pasien dalam setiap tindakan keperawatan, seperti identifikasi pasien, komunikasi efektif, pencegahan infeksi dan pencegahan risiko pasien jatuh (De Groot et al., 2019; Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2017; Wang, Yu, & Hailey, 2015).

Perlu untuk diingat bahwa tidak semua standar keperawatan dapat digunakan dalam audit keperawatan. Pemilihan standar harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria relevansi, keterukuran, keberlakuan dan kesesuaian dengan tujuan audit. Relevansi standar harus sesuai dengan area atau aspek keperawatan yang akan diaudit, dokumentasi keperawatan atau asuhan keperawatan pasien kronis. Selanjutnya adalah keterukuran yaitu standar harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga memudahkan penilaian objektif. Kemudian keberlakuan yang berarti standar yang digunakan harus sesuai dengan konteks hukum, kebijakan, atau pedoman profesional keperawatan yang berlaku saat ini dan kesesuaian dengan tujuan audit yang berarti standar yang dipilih harus mendukung tujuan spesifik audit, seperti meningkatkan efisiensi pelayanan keperawatan atau memastikan kepatuhan terhadap prosedur keperawatan tertentu.

Penetapan standar yang digunakan dalam audit keperawatan melibatkan proses yang sistematis dimulai dari identifikasi ruang lingkup audit keperawatan yang akan dilakukan seperti ruang rawat inap atau ruang rawat intensif hingga pemilihan standar audit yang relevan. Tim audit keperawatan dan stakeholder terkait perlu dilibatkan dalam memastikan kesesuaian standar dengan tujuan audit dilakukan. Standar ini kemudian di terjemahkan kedalam instrumen audit seperti lembar observasi, checklist dan sebagainya. Standar yang jelas memegang peranan penting dalam mendukung proses audit keperawatan yang konsisten dan akurat (De Groot et al., 2019). Dengan standar yang tepat maka audit keperawatan akan menjadi alat yang handal untuk mengevaluasi mutu pelayanan dan menciptakan budaya kerja yang berfokus pada kualitas dan keselamatan pasien.

E. Metode Audit Keperawatan

Audit keperawatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, mencakup tiga aspek utama: struktur, proses, dan hasil. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan menjadi kerangka kerja penting untuk menilai mutu pelayanan keperawatan. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Avedis

Donabedian dan telah diadaptasi secara luas dalam berbagai bidang pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan (Iula et al., 2020; McCullough et al., 2023).

Audit struktur audit yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas, sumber daya, dan sistem yang mendukung pelayanan keperawatan. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang menjadi dasar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan, seperti: Sumber Daya Manusia: Kualifikasi, kompetensi, dan jumlah perawat yang tersedia harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan; Fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan: Kondisi dan ketersediaan alat keperawatan, ruang perawatan, serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas perawat; Kebijakan dan SOP: Adanya pedoman kerja yang jelas, seperti pedoman pelayanan keperawatan, alur pelayanan keperawatan, panduan pelayanan keperawatan, standar prosedur operasional keperawatan juga menjadi elemen penting dalam audit struktur (Iula et al., 2020). Struktur yang memadai menjadi dasar untuk terselenggaranya pelayanan keperawatan yang berkualitas. Jika aspek struktur ini tidak cukup representatif dapat dipastikan proses dan hasil yang diharapkan juga sulit untuk dicapai.

Audit proses berfokus pada bagaimana pelayanan keperawatan terapkan atau dilaksanakan. Aspek ini menilai kepatuhan perawat terhadap pedoman, panduan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa elemen penting dalam audit proses meliputi: Penerapan Prosedur Keperawatan: Apakah perawat mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan benar saat memberikan perawatan kepada pasien, seperti teknik aseptik, administrasi obat, atau komunikasi dengan pasien; Pendokumentasian: evaluasi terhadap kelengkapan dan keakuratan catatan medis keperawatan, yang menjadi bukti bahwa tindakan telah dilakukan sesuai standar yang berlaku di fasilitas kesehatan tersebut; Komunikasi dan Koordinasi: Bagaimana perawat berinteraksi dengan pasien, keluarga, serta tim medis lainnya (Iula et al., 2020). Tujuan utama dari audit proses adalah memastikan bahwa layanan keperawatan yang diberikan telah sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan tersebut.

Audit hasil menilai luaran dari pelayanan keperawatan. Aspek ini mencakup indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan intervensi keperawatan, seperti: kondisi kesehatan pasien: apakah pasien mengalami perbaikan, stabilitas, atau bahkan penurunan setelah menerima pelayanan keperawatan; Tingkat Kepuasan Pasien: evaluasi terhadap bagaimana pasien dan keluarganya memandang kualitas layanan yang diberikan; Keselamatan Pasien: penilaian terhadap insiden keselamatan, seperti kejadian infeksi atau kesalahan dalam pemberian obat oleh perawat (Iula et al., 2020). Audit hasil memberikan gambaran

apakah tujuan pelayanan keperawatan tercapai. Meskipun hasil yang baik menjadi indikator keberhasilan, penting untuk diingat bahwa hasil juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali perawat, seperti kondisi kesehatan awal pasien atau dukungan dari keluarga.

Ketiga komponen audit struktur, proses, dan hasil tidak dapat dipisahkan. Struktur yang memadai akan mendukung pelaksanaan proses yang sesuai standar, dan proses yang baik akan meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil yang optimal. Sebaliknya, jika salah satu komponen lemah, akan sulit untuk mencapai mutu layanan keperawatan yang yang diharapkan. Sebagai contoh, jika audit struktur menemukan bahwa jumlah perawat di sebuah unit perawatan tidak mencukupi, maka kemungkinan besar proses keperawatan akan terganggu, seperti tertundanya pemberian obat atau kurangnya waktu perawat untuk melakukan komunikasi dengan pasien. Akibatnya, hasil pelayanan seperti tingkat kepuasan pasien dapat menurun.

Audit keperawatan juga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kualitas pelayanan. Dalam pelaksanaannya, auditor menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif atau bahkan keduanya secara bersamaan. Kedua metode ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan peran yang saling melengkapi, sehingga hasil audit dapat lebih akurat dan relevan dengan situasi nyata di lapangan (Christina et al., 2016).

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk data numerik yang dapat diukur dan dihitung. Data ini biasanya diperoleh dari catatan keperawatan, laporan statistik, dan dokumen lain yang tersedia dalam bentuk angka. Beberapa aspek penting dari metode kuantitatif dalam audit keperawatan meliputi: Pengumpulan Data Numerik Data kuantitatif dikumpulkan untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang telah ditentukan. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, atau perbedaan yang signifikan. Hasil analisis ini memberikan gambaran objektif tentang tingkat kualitas layanan. Pendekatan ini mempunyai keunggulan untuk memberikan hasil yang objektif dan dapat dibandingkan; mempermudah pengukuran keberhasilan pencapaian standar dan efisien untuk mengevaluasi data dalam jumlah besar. Meski demikian, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat menggali aspek-aspek nonnumerik. Disisi lain pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi yang bersifat deskriptif, terkait pengalaman, persepsi, atau pendapat dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan keperawatan (Christina et al., 2016). Data ini biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, atau diskusi kelompok dan lain sebagainya. Data kualitatif diperoleh dari interaksi langsung dengan individu atau kelompok, seperti: Wawancara mendalam dengan perawat, pasien, atau keluarga

pasien atau observasi terhadap perilaku perawat saat memberikan perawatan; Diskusi kelompok terarah untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan prosedur keperawatan. Pendekatan kualitatif memungkinkan auditor untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak terjangkau oleh data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema, pola, atau kategori dari hasil wawancara atau observasi. Proses ini memerlukan interpretasi yang mendalam untuk memahami konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif mempunyai beberapa keunggulan diantaranya adalah peluang terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan alasan di balik suatu masalah; Mampu menggali pengalaman dan persepsi individu yang tidak terukur secara kuantitatif dan menyediakan ketersediaan wawasan tentang aspek emosional atau sosial yang turut memengaruhi kualitas pelayanan. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pengumpulan data dan analisis, serta cenderung bersifat subjektif jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Pendekatan berikutnya yang dapat dilakukan dalam audit keperawatan adalah Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam audit keperawatan memberikan manfaat yang signifikan. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran umum dan objektif tentang tingkat pencapaian standar, sedangkan pendekatan kualitatif melengkapi dengan memberikan pemahaman mendalam tentang latar belakang temuan kuantitatif. Contohnya: Jika data kuantitatif menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan perawat terhadap prosedur pendokumentasian keperawatan, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menggali alasan di baliknya. Kombinasi ini juga membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran, karena didasarkan pada analisis yang menyeluruh dari berbagai aspek pelayanan.

F. Penggunaan Teknologi dalam Audit Keperawatan

Audit keperawatan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan teknologi dalam audit keperawatan menjadi elemen penting dalam peningkatan efisiensi, akurasi, dan kualitas audit Keperawatan. Salah satu teknologi yang paling banyak dimanfaatkan adalah Sistem Informasi Kesehatan Elektronik (EHR). EHR memungkinkan auditor untuk mengakses catatan medis pasien secara digital, termasuk riwayat perawatan dan pencatatan tindakan keperawatan (Hirsch et al., 2016). Dengan kemudahan ini, proses audit menjadi lebih cepat, akurat, dan terhindar dari kesalahan yang sering muncul pada sistem manual. Di samping itu, aplikasi mobile dan perangkat wearable memberikan

kontribusi besar dalam proses ini (Pei-Ying, Chen-Shie, & Pei-Hung, 2021). Perangkat seperti monitor kesehatan yang terintegrasi dengan sistem rumah sakit memungkinkan pencatatan data secara real-time, memberikan informasi penting terkait kondisi pasien yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi (Rule, Chiang, & Hribar, 2019). Teknologi ini mendukung perawat dalam memantau pasien dengan lebih efisien sambil tetap mematuhi standar keperawatan. Keunggulan lain teknologi datang dari pemanfaatan big data. Dengan analisis data berskala besar, auditor dapat menemukan pola dan tren pelayanan yang sebelumnya sulit teridentifikasi (Dicuonzo, Galeone, Shini, & Massari, 2022). Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam dan perencanaan perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, dashboard kinerja dan sistem pelaporan otomatis memberikan visualisasi indikator kualitas secara langsung, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Teknologi juga menyederhanakan proses dokumentasi, di mana penggunaan perangkat lunak modern mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaporan (Pei-Ying et al., 2021). Dengan cara ini, audit keperawatan tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan serta keselamatan pasien secara berkelanjutan.

G. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Audit Keperawatan

Meskipun audit keperawatan memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan sering kali dihadapi oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam melaksanakan audit keperawatan secara efektif. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan solusi yang tepat. Berikut ini adalah beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam implementasi audit keperawatan beserta solusi yang dapat diterapkan:

1. **Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih.** Salah satu tantangan utama dalam implementasi audit keperawatan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten dalam melakukan audit keperawatan (Gude et al., 2018). Banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan kekurangan tenaga auditor keperawatan yang memiliki keterampilan khusus dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan. Untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit harus berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi perawat yang terlibat dalam audit. Program pelatihan audit keperawatan dapat diadakan secara reguler untuk meningkatkan kemampuan staf keperawatan dalam melakukan audit. Selain itu, kerjasama dengan pihak

- eksternal, seperti institusi pendidikan atau organisasi profesi, juga bisa membantu dalam menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi auditor internal.
2. Resisten terhadap Perubahan dari Staf Keperawatan. Implementasi audit keperawatan sering kali menghadapi resistensi dari staf keperawatan yang merasa khawatir dengan dampak audit terhadap pekerjaan mereka (Christina et al., 2016). Beberapa perawat mungkin merasa takut atau cemas terhadap hasil audit yang bisa mempengaruhi reputasi mereka atau menambah beban kerja mereka. Oleh karena itu sangat penting untuk mengkomunikasikan tujuan dan manfaat audit keperawatan yang dilakukan dengan jelas kepada seluruh staf keperawatan. Audit harus diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sebagai proses untuk menghakimi apalagi sebagai alat untuk menjatuhkan hukuman. Melibatkan staf dalam proses audit sejak awal, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan pemahaman tentang bagaimana audit dapat mendukung perkembangan profesional mereka dapat mengurangi resistensi. Selain itu, pengakuan terhadap pencapaian dan perbaikan yang dilakukan setelah audit akan membantu meningkatkan partisipasi mereka (Christina et al., 2016).
 3. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu sering menjadi kendala dalam pelaksanaan audit keperawatan. Perawat yang memiliki jadwal padat sering kali kesulitan untuk meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam audit atau menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan audit. Untuk mengatasi tantangan ini, manajemen rumah sakit dapat merancang jadwal audit yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional rumah sakit. Audit bisa dilakukan dalam periode tertentu yang tidak mengganggu jam kerja utama perawat. Selain itu, pembagian tugas secara efisien di antara anggota tim audit dapat membantu membagi beban kerja dan memastikan bahwa audit berjalan tanpa mengganggu pelayanan pasien.
 4. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi. Penerapan teknologi dalam audit keperawatan sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya teknologi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sistem informasi yang terintegrasi atau perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan audit keperawatan yang efektif (Hirsch et al., 2016; Rule et al., 2019). Untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit harus berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi. Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Elektronik (EHR) yang dapat mengintegrasikan data medis dan catatan keperawatan akan mempermudah proses audit (Rule et al., 2019). Jika infrastruktur yang ada terbatas, rumah sakit bisa memulai dengan menggunakan perangkat teknologi yang lebih sederhana dan perlahan

meningkatkan kapasitasnya seiring dengan waktu dan anggaran yang tersedia. Pelatihan untuk staf IT rumah sakit juga penting untuk memastikan sistem yang ada dapat mendukung pelaksanaan audit secara efektif.

5. Ketidakpastian dalam Standar dan Kriteria Audit. Sering kali terdapat kebingungannya tentang standar atau kriteria yang harus digunakan dalam audit keperawatan. Standar yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara auditor dan perawat, yang akhirnya berdampak pada hasil audit yang kurang akurat (De Groot et al., 2019). Untuk permasalahan seperti ini Pengembangan dan penetapan standar yang jelas dan terukur sangat penting untuk kelancaran audit keperawatan. Standar ini harus didasarkan pada pedoman klinis yang telah diakui dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk perawat dan manajer rumah sakit. Selain itu, standar harus bersifat fleksibel dan dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan dan kebutuhan fasilitas kesehatan.
6. Kurangnya Dukungan Manajemen. Tanpa dukungan yang kuat dari manajemen puncak rumah sakit atau fasilitas kesehatan, pelaksanaan audit keperawatan sering kali kurang mendapat perhatian dan sumber daya yang memadai. Manajemen yang tidak memahami pentingnya audit dapat menyebabkan kurangnya komitmen untuk menyediakan anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan (Wang et al., 2015). Oleh sebab itu penting untuk memastikan bahwa manajemen rumah sakit memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat audit keperawatan dan dampaknya terhadap peningkatan mutu layanan. Ini bisa dicapai melalui presentasi, laporan, atau diskusi dengan pihak manajerial yang menunjukkan bagaimana audit dapat berkontribusi pada pengurangan biaya, peningkatan kepuasan pasien, dan perbaikan kualitas pelayanan. Dukungan manajerial yang kuat dapat mencakup penyediaan anggaran untuk pelatihan, pengembangan sistem informasi, dan penyediaan waktu yang cukup bagi perawat untuk berpartisipasi dalam audit.
7. Pengelolaan Data yang Kompleks. Pengumpulan dan analisis data dalam audit keperawatan bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika melibatkan data dari berbagai sumber yang berbeda (Hut-Mossel et al., 2021). Data yang tidak terorganisir atau tidak terstruktur dengan baik bisa menyulitkan tim auditor untuk menarik kesimpulan yang akurat. Tantangan seperti ini dapat diatasi dengan memiliki sistem manajemen data yang baik, baik melalui perangkat lunak atau aplikasi khusus yang memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Proses pengolahan data harus dilakukan dengan standar yang jelas dan menggunakan teknologi yang memungkinkan pengolahan data secara otomatis dan efisien. Menggunakan platform yang memungkinkan tim audit

untuk berbagi data dengan mudah dan memvisualisasikan hasil audit akan membantu meningkatkan keakuratan dan kemudahan pengelolaan data.

H. Penutup

Audit keperawatan merupakan suatu proses evaluasi terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Tujuan audit keperawatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Audit keperawatan dilakukan secara sistematis menggunakan instrumen yang relevan dan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, kualitatif atau perpaduan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan pada struktur, proses dan outcome. Luaran dari audit keperawatan adalah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi tersebut bersifat anonim Tidak menyalahkan dan tidak untuk mempermalukan dan rekomendasi yang diberikan harus kongkrit, dapat dilaksanakan serta berfokus kepada masalah yang ditemukan. Dalam melaksanakan audit keperawatan teknologi terkini dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk efektifitas dan efisiensi. Meskipun audit keperawatan sangat penting untuk dilakukan tidak serta merta audit keperawatan bebas dari tantangan tetapi semua tantangan tersebut dapat di atasi dengan penerapan solusi yang tepat.

I. Referensi

- Christina, V., Baldwin, K., Biron, A., Emed, J., & Lepage, K. (2016). Factors influencing the effectiveness of audit and feedback: nurses' perceptions. *Journal of nursing management*, 24(8), 1080-1087.
- De Groot, K., Triemstra, M., Paans, W., & Francke, A. L. (2019). Quality criteria, instruments, and requirements for nursing documentation: A systematic review of systematic reviews. *Journal of advanced nursing*, 75(7), 1379-1393.
- Dicuonzo, G., Galeone, G., Shini, M., & Massari, A. (2022). Towards the Use of Big Data in Healthcare: A Literature Review. *Healthcare*, 10(7), 1232.
- Effendi, E. (2018). Pengaruh kinerja manajemen mutu, manajemen pemasaran dan audit internal terhadap akreditasi pelayanan rumah sakit swasta di pekan baru. *Jurnal kompetitif*, 7(2).
- Gomez, N. J. (2017). Audits: is audit a four-letter word? *Nephrology Nursing Journal*, 44(4), 355.
- Gude, W. T., Roos-Blom, M.-J., van der Veer, S. N., Dongelmans, D. A., de Jonge, E., Francis, J. J., . . . de Keizer, N. F. (2018). Health professionals' perceptions about their clinical performance and the influence of audit and feedback

- on their intentions to improve practice: a theory-based study in Dutch intensive care units. *Implementation Science*, 13(1), 33. doi:10.1186/s13012-018-0727-8
- Hirsch, A. G., Jones, J. B., Lerch, V. R., Tang, X., Berger, A., Clark, D. N., & Stewart, W. F. (2016). The electronic health record audit file: the patient is waiting. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 24(e1), e28-e34. doi:10.1093/jamia/ocw088
- Hut-Mossel, L., Ahaus, K., Welker, G., & Gans, R. (2021). Understanding how and why audits work in improving the quality of hospital care: A systematic realist review. *PloS one*, 16(3), e0248677.
- Iula, A., Ialungo, C., de Waure, C., Raponi, M., Burgazzoli, M., Zega, M., . . . Damiani, G. (2020). Quality of Care: Ecological Study for the Evaluation of Completeness and Accuracy in Nursing Assessment. *Int J Environ Res Public Health*, 17(9). doi:10.3390/ijerph17093259
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2017). *Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1* (I ed.): Komisi Akreditasi Rumah Sakit, .
- Masamah, S., Fransiska, D., Safenti, K., & Rianjani, R. (2023). Audit Dokumentasi Asuhan Keperawatan. *The Journal of Hospital Accreditation*, 5(01), 32-34.
- McCullough, K., Andrew, L., Genoni, A., Dunham, M., Whitehead, L., & Porock, D. (2023). An examination of primary health care nursing service evaluation using the Donabedian model: A systematic review. *Research in Nursing & Health*, 46(1), 159-176. doi:<https://doi.org/10.1002/nur.22291>
- Michl, G., Bail, K., Turner, M., & Paterson, C. (2024). Identifying the impact of audit and feedback on the professional role of the nurse and psychological well-being: An integrative systematic review. *Nursing & Health Sciences*, 26(1), e13095. doi:<https://doi.org/10.1111/nhs.13095>
- Michl, G., Paterson, C., & Bail, K. (2023). 'It's all about ticks': A secondary qualitative analysis of nurse perspectives about documentation audit. *Journal of advanced nursing*, 79(9), 3440-3455.
- Pei-Ying, K., Chen-Shie, H., & Pei-Hung, L. (2021). The impact of a multilevel interactive nursing quality control and audit application on nursing quality management. *BMC nursing*, 20, 1-11.
- Rule, A., Chiang, M. F., & Hribar, M. R. (2019). Using electronic health record audit logs to study clinical activity: a systematic review of aims, measures, and methods. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(3), 480-490. doi:10.1093/jamia/ocz196

- Senna, C., Martins, T., Kammers, T., Amante, L., & Sell, B. (2017). Nursing audit: an integrating review in theses and dissertations. *Nurse Care Open Acces J. v4 (2)*, 396-400.
- Sinuff, T., Muscedere, J., Rozmovits, L., Dale, C. M., & Scales, D. C. (2015). A qualitative study of the variable effects of audit and feedback in the ICU. *BMJ quality & safety*, 24(6), 393-399.
- Wang, N., Yu, P., & Hailey, D. (2015). The quality of paper-based versus electronic nursing care plan in Australian aged care homes: A documentation audit study. *International Journal of Medical Informatics*, 84(8), 561-569. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.04.004>

CHAPTER 3

PENGELOLAAN RISIKO DALAM KEPERAWATAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.

A. Pendahuluan

Pengelolaan risiko dalam keperawatan telah menjadi isu yang semakin penting di era modern ini, di mana tuntutan akan kualitas layanan kesehatan semakin meningkat. Dengan kompleksitas kasus yang semakin tinggi dan ekspektasi pasien yang terus berubah, perawat dituntut untuk dapat mengidentifikasi serta mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan. Kohn et al. (1999) dalam laporan "To Err Is Human" menyoroti tingginya angka kesalahan medis yang terjadi di rumah sakit, yang semakin menegaskan pentingnya pengelolaan risiko yang sistematis dalam praktik keperawatan. Hal ini sejalan dengan panduan dari World Health Organization/WHO (2019) yang menekankan pentingnya keselamatan pasien dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan global.

Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan risiko tidak hanya dapat mengurangi insiden yang tidak diinginkan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kepuasan pasien dan reputasi institusi kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Browne dan McCarthy (2020), ditemukan bahwa strategi pengelolaan risiko yang tepat dapat meningkatkan interaksi antara staf kesehatan dan pasien, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pengalaman pasien. Oleh karena itu, penguatan kompetensi perawat dalam manajemen risiko menjadi krusial.

Buku ini ditulis untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan risiko di lingkungan keperawatan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti identifikasi risiko, analisis, dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, buku ini akan membahas pentingnya membangun budaya keselamatan yang kuat di antara tenaga kesehatan, yang diakui sebagai faktor penting dalam mencapai keselamatan pasien (Bagnasco et al., 2019).

Dengan menyajikan contoh kasus dan praktik terbaik, buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan bagi perawat dan profesional kesehatan lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan risiko, diharapkan

kualitas layanan keperawatan dapat ditingkatkan dan keselamatan pasien dapat terjamin.

B. Konsep Dasar Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dalam keperawatan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk identifikasi, analisis, dan penanganan risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan keperawatan. Dalam konteks ini, pengelolaan risiko bukan hanya tentang mencegah kejadian yang merugikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan kepuasan pasien. Bagian ini akan membahas beberapa aspek penting dari konsep dasar pengelolaan risiko dalam keperawatan, termasuk pengertian risiko, jenis-jenis risiko, serta pentingnya pengelolaan risiko bagi perawatan dan kualitas layanan.

1. Pengertian Risiko dalam Keperawatan

Risiko dalam keperawatan adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien, mulai dari efek samping pengobatan hingga kesalahan prosedur. Menurut Vincent (2010), risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian, cedera, atau kerusakan sebagai akibat dari suatu tindakan. Dalam keperawatan, risiko dapat berakibat fatal dan dapat berpengaruh langsung pada *outcome* pasien.

2. Jenis-jenis Risiko

Pengelolaan risiko dalam keperawatan melibatkan berbagai jenis risiko yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: risiko klinis dan risiko non-klinis.

- a. Risiko Klinis : Ini mencakup semua risiko yang berhubungan dengan tindakan medis dan perawatan langsung kepada pasien. Contohnya termasuk:
 - 1) Kesalahan Administrasi Obat: Memberikan dosis yang salah atau obat yang salah kepada pasien.
 - 2) *Healthcare Assosiated Infection* (HAIs) : Infeksi yang diperoleh pasien selama dirawat di rumah sakit.
 - 3) Kesalahan Diagnosis: Diagnosis yang tidak akurat yang dapat mengarah pada penanganan yang tidak tepat (Kohn et al., 2000).
- b. Risiko Non Klinis: Risiko ini berkaitan dengan manajemen dan operasional dalam lingkungan rumah sakit. Ini meliputi:
 - 1) Risiko Hukum: Menghadapi tuntutan hukum akibat kelalaian atau kesalahan dalam perawatan.
 - 2) Masalah Keuangan: Kerugian finansial akibat insiden yang tidak terduga.

- 3) Reputasi : Dapat terpengaruh oleh insiden yang merugikan yang dapat mengurangi kepercayaan publik (*World Health Organization*, 2019).

3. Pentingnya Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko yang efektif dalam keperawatan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas layanan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan risiko sangat penting:

- a. Meningkatkan Keselamatan Pasien: Dengan mengidentifikasi dan menangani risiko, perawat dapat mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan meningkatkan keselamatan pasien.
- b. Meningkatkan Kualitas Layanan: Pengelolaan risiko yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kepuasan pasien.
- c. Mengurangi Biaya: Insiden yang tidak diinginkan dapat membawa dampak finansial yang signifikan bagi rumah sakit. Pengurangan insiden dapat mengarah pada penghematan biaya yang besar (Ferrell & Coyle, 2010).
- d. Membangun Budaya Keselamatan: Pengelolaan risiko yang sistematis dapat menciptakan budaya keselamatan dalam organisasi, yang mendorong keterlibatan staf dalam peningkatan kualitas dan keselamatan.

Pengelolaan risiko dalam keperawatan merupakan landasan penting untuk mencapai standar tinggi dalam kualitas layanan kesehatan. Dengan memahami berbagai jenis risiko dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengelolanya, perawat dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berfokus pada pasien. Pengetahuan ini bukan hanya bermanfaat bagi perawatan individu, tetapi juga untuk pengembangan sistem kesehatan yang lebih baik.

C. Pendekatan Dalam Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dalam keperawatan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai tahapan untuk menganalisis, menilai, dan mengurangi dampak risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko dalam keperawatan, termasuk pendekatan risk management, audit, dan pemantauan.

1. Pendekatan *Risk Management*

Pendekatan *Risk Management* (RM) adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam pengelolaan risiko dalam keperawatan. RM adalah proses sistematis yang melibatkan analisis, penilaian, dan pengurangan risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan.

- a. Identifikasi Risiko: Tahap ini melibatkan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan.
- b. Analisis Risiko: Tahap ini melibatkan analisis risiko yang sudah dideteksi, termasuk kemungkinan terjadinya risiko, akibatnya jika risiko terjadi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko.
- c. Pengurangan Risiko: Tahap ini melibatkan pengurangan risiko yang sudah dianalisis, termasuk implementasi kebijakan yang efektif dan pelatihan staf.

Pendekatan RM telah dipertimbangkan sangat efektif dalam mengurangi insiden yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas layanan (Kohn et al., 2000).

2. Pendekatan Audit

Pendekatan audit adalah proses sistematis yang melibatkan evaluasi sistem dan proses untuk menilai efektivitasnya dalam mengurangi risiko. Audit dapat meliputi:

- a. Audit Sistem: Audit sistem untuk menilai efektivitas sistem dalam mengurangi risiko.
- b. Audit Proses: Audit proses untuk menilai efektivitas proses dalam mengurangi risiko.
- c. Audit Kinerja: Audit kinerja untuk menilai efektivitas kinerja individu atau tim dalam mengurangi risiko.

Pendekatan audit telah dipertimbangkan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi insiden yang tidak diinginkan (Vincent, 2010).

3. Pendekatan Pemantauan

Pendekatan pemantauan adalah proses sistematis yang melibatkan pengawasan dan pengawasan terhadap risiko yang sudah dianalisis. Pemantauan dapat meliputi:

- a. Pemantauan Risiko: Pemantauan risiko yang sudah dianalisis untuk menilai efektivitas pengurangan risiko.
- b. Pemantauan Proses: Pemantauan proses untuk menilai efektivitas proses dalam mengurangi risiko.
- c. Pemantauan Kinerja: Pemantauan kinerja untuk menilai efektivitas kinerja individu atau tim dalam mengurangi risiko.

Pendekatan pemantauan telah dipertimbangkan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi insiden yang tidak diinginkan (World Health Organization, 2019).

Pengelolaan risiko dalam keperawatan melibatkan berbagai pendekatan untuk menganalisis, menilai, dan mengurangi dampak risiko yang dapat

mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan. Pendekatan risk management, audit, dan pemantauan adalah beberapa contoh pendekatan yang efektif digunakan dalam pengelolaan risiko. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, perawat dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi insiden yang tidak diinginkan.

D. Peran Perawat dalam Pengelolaan Risiko

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko dalam keperawatan. Mereka bertanggung jawab untuk menganalisis, menilai, dan mengurangi dampak risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan.

1. Peran Utama Perawat dalam Pengelolaan Risiko

- a. Identifikasi Risiko: Perawat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan. Mereka melakukan analisis risiko dengan menggunakan metode seperti SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) atau PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*).
- b. Analisis Risiko: Perawat melakukan analisis risiko yang lebih mendalam untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko, akibatnya jika risiko terjadi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko.
- c. Pengurangan Risiko : Perawat bertanggung jawab untuk mengurangi risiko yang sudah dianalisis. Mereka menentukan strategi pengurangan risiko yang efektif dan melaksanakannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- d. Pemantauan Risiko: Perawat bertanggung jawab untuk memantau risiko yang sudah dianalisis. Mereka melakukan pemantauan terhadap risiko untuk menilai efektivitas pengurangan risiko.

2. Peran Perawat dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien

- a. Meningkatkan Kesadaran Pasien: Perawat dapat meningkatkan kesadaran pasien tentang risiko yang mereka alami. Mereka dapat memberikan informasi yang jelas dan terarah tentang risiko yang terkait dengan prosedur medis yang akan dilakukan.
- b. Mengurangi Risiko: Perawat dapat mengurangi risiko dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, melakukan prosedur medis yang lebih aman, dan meningkatkan kualitas perawatan yang dilakukan.
- c. Meningkatkan Kerja Sama: Perawat dapat meningkatkan kerja sama dengan pasien, keluarga, dan tim medis lainnya untuk meningkatkan keselamatan pasien.

3. Peran Perawat dalam Mengembangkan Budaya Keselamatan

- a. Mengembangkan Budaya Keselamatan: Perawat dapat mengembangkan budaya keselamatan di dalam tempat kerja. Mereka dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko dan pentingnya pengelolaan risiko untuk meningkatkan kualitas layanan.
- b. Meningkatkan Keterlibatan Staf: Perawat dapat meningkatkan keterlibatan staf dalam pengelolaan risiko. Mereka dapat meminta masukan dari staf tentang cara meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan.
- c. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Risiko: Perawat dapat mengembangkan sistem pengelolaan risiko yang efektif. Mereka dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko dalam keperawatan. Mereka bertanggung jawab untuk menganalisis, menilai, dan mengurangi dampak risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kualitas layanan. Dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko, perawat dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi insiden yang tidak diinginkan.

E. Kualitas Layanan dalam Keperawatan

Kualitas pelayanan kesehatan adalah konsep yang sangat penting dalam pengelolaan risiko, terutama dalam konteks keperawatan. Kualitas pelayanan tidak hanya mencakup efektifitas dan efisiensi, tetapi juga mencakup keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan pengalaman pasien secara keseluruhan. Dalam bagian ini, akan dibahas tentang dimensi kualitas layanan, indikator pengukuran kualitas, serta hubungannya dengan pengelolaan risiko dalam konteks keperawatan.

1. Dimensi Kualitas Layanan

- a. Keamanan

Dimensi keamanan dalam layanan kesehatan adalah aspek yang paling krusial, berfokus pada mencegah terjadinya cedera atau kerugian yang tidak diinginkan pada pasien sepanjang proses perawatan. Keamanan dapat dicapai melalui prosedur yang standar, pelatihan untuk perawat, dan penggunaan teknologi yang mendukung keselamatan pasien (World Health Organization, 2019).

b. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana pelayanan kesehatan memenuhi kebutuhan dan harapan pasien. Ini melibatkan penggunaan metode dan intervensi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan pasien.

c. Keterjangkauan

Keterjangkauan layanan kesehatan adalah kemampuan pasien untuk mengakses perawatan yang diperlukan, yang juga berkaitan dengan biaya, lokasi, dan ketersediaan sumber daya.

d. Keterampilan dan Keahlian

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan keterampilan dan keahlian perawat. Perawat yang terlatih dengan baik akan lebih mampu memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien.

e. Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien merupakan indikator penting dari kualitas layanan. Ini mencerminkan persepsi pasien tentang interaksi mereka dengan tim medis, proses perawatan, dan hasil dari pelayanan yang diterima.

2. Indikator Pengukuran Kualitas

Indikator pengukuran kualitas pelayanan kesehatan diperlukan untuk menilai dan meningkatkan praktik keperawatan. Beberapa indikator yang penting meliputi:

- a. Frekuensi Insiden Nyeri atau Komplikasi: Pengukuran jumlah insiden nyeri yang dialami pasien selama perawatan dapat menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- b. Waktu Respons Terhadap Permintaan Pasien: Waktu yang diperlukan oleh perawat untuk menjawab permintaan atau panggilan pasien dapat menjadi indikator penting untuk menentukan seberapa cepat dan responsif tim keperawatan.
- c. Tingkat Kepuasan Pasien: Survei kepuasan pasien dapat memberikan data berharga untuk memahami bagaimana pasien menilai layanan yang mereka terima.

3. Hubungan antara Kualitas Layanan dan Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko yang efektif dalam keperawatan sangat bergantung pada kualitas pelayanan. Ketika kualitas pelayanan meningkat, risiko yang terkait dengan kesalahan medis dan insiden tidak diinginkan juga cenderung menurun. Beberapa hubungan utama antara kualitas pelayanan dan pengelolaan risiko meliputi:

- a. Pencegahan Kesalahan Medis: Melalui penerapan praktik terbaik dan pelatihan yang tepat, pengelolaan risiko dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.
- b. Peningkatan Laporan Insiden: Kualitas laporan insiden dan analisis akar dari insiden tersebut sangat penting untuk mempelajari kesalahan dan memperbaiki prosedur. Laporan yang tepat dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan area berisiko tinggi dalam pelayanan keperawatan.
- c. Budaya Keselamatan: Membangun budaya keselamatan yang positif, di mana setiap anggota tim merasa bertanggung jawab dan nyaman untuk melaporkan kesalahan, merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kualitas layanan yang tinggi.

Kualitas pelayanan dalam keperawatan merupakan elemen kunci dalam pengelolaan risiko. Mengutamakan kualitas tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan pasien tetapi juga mengurangi kemungkinan insiden yang tidak diinginkan. Dengan meningkatkan dimensi kualitas, indikator pengukuran, dan membangun hubungan yang erat antara kualitas dan pengelolaan risiko, perawat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keselamatan dan kepuasan pasien.

F. Studi Kasus : Pengelolaan Risiko Dalam Praktek

Studi kasus merupakan alat penting dalam memahami praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko di lingkungan keperawatan. Dalam bagian ini, akan disajikan contoh studi kasus yang relevan dengan pengelolaan risiko dan bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan.

Kasus: Insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Pasien setelah Pembedahan

1. Latar Belakang

Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun menjalani operasi kantung empedu. Setelah menjalani tindakan pembedahan, pasien kembali ke ruang perawatan. Beberapa jam setelah operasi, pasien mengalami komplikasi berupa perdarahan yang tidak terduga. Hal ini menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan dan memerlukan intervensi kritis dari tim medis.

Identifikasi Risiko

- a. Kurangnya Monitoring Pasien: Setelah operasi, perawat tidak memberikan pemantauan yang cukup pada tanda-tanda vital pasien, terutama dalam jam-jam kritis pasca bedah.

- b. Komunikasi yang Buruk: Kurangnya komunikasi antara anesthesi dan perawat mengenai kondisi pasien saat pemulangan dari ruang operasi berkontribusi pada keterlambatan dalam identifikasi komplikasi.
- c. Protokol Keamanan yang Tidak Memadai: Tidak adanya protokol tertulis untuk pemantauan pasien pasca operasi yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh tim keperawatan.

2. Analisis Kasus

Setelah melakukan analisis akar penyebab (*Root Cause Analysis/RCA*), beberapa faktor yang menjadi penyebab kejadian tidak diinginkan ini diidentifikasi:

- a. Prosedur Standar yang Tidak Diikuti: Prosedur monitoring dan pengawasan pasca-operasi tidak diikuti berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- b. Keterbatasan Pelatihan Staf: Banyak perawat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya dan prosedur untuk pemantauan pasien pasca-operasi yang berisiko tinggi.
- c. Budaya Keselamatan yang Lemah: Tidak adanya budaya keamanan yang memadai di lingkungan kerja, sehingga staf merasa takut untuk melaporkan masalah atau kekhawatiran.

3. Tindakan Perbaikan

- a. Pelatihan Ulang Staf: Mengadakan sesi pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman staf tentang pentingnya pemantauan pasca operasi, termasuk mencakup cara mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi awal.
- b. Pengembangan Protokol: Mengembangkan protokol pemantauan yang jelas dan menyeluruh bagi pasien pasca-operasi. Protokol ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh perawat, frekuensi monitoring, dan cara melaporkan temuan abnormal.
- c. Membangun Budaya Keselamatan: Mendorong budaya keselamatan di mana setiap anggota tim dapat melaporkan masalah dan berpartisipasi dalam diskusi tentang keamanan pasien. Hal ini dapat dilakukan melalui forum ketika melakukan tinjauan kasus dan berbagi pengalaman.

4. Hasil

Setelah implementasi tindakan perbaikan ini, unit perawatan pasien pasca-operasi mengalami penurunan signifikan dalam insiden KTD terkait pembedahan. Tingkat kepuasan pasien juga meningkat, karena pasien merasa lebih aman dan terawasi selama masa pemulihan.

Studi kasus ini menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko dalam keperawatan dan bagaimana tindakan proaktif dapat mencegah kejadian tidak diinginkan yang serius. Melalui pelatihan, pengembangan prosedur, dan

membangun budaya kesadaran keamanan, layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

G. Kesimpulan

Pembahasan secara komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan risiko dalam keperawatan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dalam pengelolaan risiko, para perawat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pelayanan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien.

Keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pelayanan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Dengan demikian, perawat memiliki tanggung jawab untuk mengenali potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya. dimensi kualitas pelayanan dalam konteks keperawatan, seperti keamanan, efektivitas, keterjangkauan, dan kepuasan pasien. Memahami dimensi ini membantu perawat dalam merancang dan melaksanakan intervensi yang lebih baik.

Selain itu, pentingnya budaya keselamatan dalam pengelolaan risiko. Menciptakan budaya keselamatan adalah esensial dalam pengelolaan risiko, termasuk mendorong komunikasi yang terbuka, pelaporan insiden tanpa takut akan konsekuensi, dan melibatkan seluruh anggota tim kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan layanan.

Dengan penekanan pada pengelolaan risiko, buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi perawat dan manajer layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Memadukan teori dengan praktik, serta pengalaman dunia nyata, buku ini adalah sumber yang berharga dalam usaha menciptakan sistem perawatan yang lebih baik dan lebih aman untuk pasien.

H. Referensi

- Bagnasco, A., Timonen, V., & Kearns, R. A. (2019). Management of Risks in Nursing: Challenges and Opportunities. *Nursing Management Quarterly*, 43(1), 67-75.
- Berwick, D. M. (2002). A User's Manual for the IOM's "Crossing the Quality Chasm": A New Health System for the 21st Century. *Health Affairs*, 21(3), 80-90.
- Browne, E., & McCarthy, G. (2020). Enhancing Patient Safety: The Role of Nursing in Risk Management. *Journal of Nursing Administration*, 50(12), 650-655.
- Donabedian, A. (1988). The Quality of Care: How Can It Be Assessed. *JAMA*, 260(12), 1743-1748.

- Ferrell, B. R., & Coyle, N. (2010). The Nature of Suffering and the Goals of Nursing. *In Oxford Textbook of Palliative Nursing*. New York: Oxford University Press.
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). To Err is Human: Building a Safer Health System. Washington, D.C.: *National Academy Press*.
- Pflege, T. S., & Schubert, K. (2016). Risk Management in Nursing: A Practical Guide. London: *Sage Publications*
- Vincent, C. (2010). Patient Safety. Wiley-Blackwell.
- World Health Organization. (2019). Global Action on Patient Safety: A Patient Safety Strategy. Retrieved from [WHO](<https://www.who.int/publications/i/item/9789241514435>).

I. Glosarium

HAIs	= <i>Healthcare Assosiated Infection</i>
KTD	= Kejadian Tidak Diharapkan
PESTEL	= Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal
RM	= Risk Management
RCA	= <i>Root Cause Analysis</i>
SWOT	= Strength, Weakness, Opportunity, Threat
WHO	= World Health Organization

CHAPTER 4

PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KEPERAWATAN

Ns. Eliza, S.Pd., S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi di era komputer saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas perawatan di rumah sakit yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan perawatan medis berkualitas kepada pasien, misalnya melalui penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). Memudahkan Anda memenuhi kebutuhan.) dan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) sangat penting untuk memusatkan data pasien dan memungkinkan perawat mengakses informasi dengan cepat dan akurat, yang memungkinkan perawatan pasien lebih baik dan lebih efisien. Hal ini memudahkan pemberian layanan yang cepat. (Eliza, Hema Marini, Novrianda, 2018).

Di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, manajemen informasi dalam keperawatan sangat penting. Dipercaya bahwa sistem yang dilaksanakan di rumah sakit yang berbasis teknologi informasi memiliki berbagai jenis kegiatan pelayanan keperawatan dapat diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi di rumah sakit. seperti contoh dalam pelaksanaan dokumentasi keperawatan. Dalam sistem rekam medis menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh staf medis selama merawat pasien di rumah sakit. Beban yang ditanggung oleh staf perawat sangatlah berat, maka dengan pencatatan digital diharapkan dapat meringankan beban kerja tersebut dibandingkan pencatatan secara manual (Nugroho *et al.*, 2023).

Peningkatan mutu pelayanan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan dengan efisensi yang memastikan pengembangan pelayanan asuhan kesehatan atau keperawatan tercapai secara optimal sesuai standar profesi dan pelayanan yang dapat dilaksanakan secara komprehensif sesuai kebutuhan pasien dengan menggunakan teknologi tepat guna. (Zendrato, 2022)

Dalam memberikan pelayanan keperawatan, kepuasan pasien selalu menjadi prioritas utama dan merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan. Pelayanan keperawatan yang berkualitas akan menimbulkan kepuasan pasien. Jika pasien

benar-benar puas, mereka akan merekomendasikan pelayanan rumah sakit kepada orang lain sehingga rumah sakit tersebut akan diminati oleh masyarakat untuk pelayanan kesehatannya. Oleh sebab itu, rumah sakit mulai berpikir lebih matang mengenai pentingnya pelayanan kepada pasien melalui kualitas pelayanan, mengingat pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah faktor yang sangat berperan penting agar dapat bertahan dan meningkatkan daya saing dalam dunia bisnis (Nurnainah, Novian Aldo, 2024)

Teknologi memberdayakan pasien dan kebutuhan akan layanan dan perawatan kesehatan sangat penting bagi mereka. Selain itu, pasien menginginkan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas tinggi (Susilowati, 2013). Telenursing juga sering digunakan yang merupakan teknologi dalam memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan medis kepada pasien dari jarak jauh, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan (Humam, 2021).

Menurut (Sari Dian Kumala, Bintaria Ayu Purwandrari, 2023) manfaat telenursing bagi pengasuh antara lain peningkatan pendapatan, jam kerja yang fleksibel, pengurangan biaya perjalanan karena pengasuh memberikan layanan dari rumah, layanan hanya diberikan dari jarak jauh, dan kepuasan kerja. dan peningkatan kesempatan untuk pengembangan keterampilan, pilihan karir baru, data bersama dan peningkatan respons waktu. Keuntungan telecare bagi pasien adalah masyarakat di daerah terpencil dapat menerima perawatan medis selama mereka memiliki akses internet melalui telepon seluler atau komputer, dan karena pasien tidak perlu bepergian ke rumah sakit, telecare menawarkan biaya rendah dan biaya perawatan tinggi. - perawatan berkualitas. Akses mudah ke layanan medis. Saya harus bepergian ke Amerika. tempat. Jauh sekali (Fadhila and Afriani, 2019).

Namun pemanfaatan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif bagi penggunaannya. Agar pelayanan keperawatan dapat diterima oleh pasien dan masyarakat, banyak hal yang mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan. Selain itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk mengukur tingkat kepuasan pasien sebagai konsumen dan peran teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan untuk mengonfirmasi dan mengatasi kekhawatiran yang ada terkait teknologi.

B. Kualitas Layanan

1. Pengertian Kualitas

(Zuliatika and Purnamawati, 2024) Kami percaya bahwa kualitas berarti mencapai persyaratan yang diberikan. Kualitas berarti memenuhi kebutuhan. Kualitas yang buruk dapat disebabkan oleh hasil pelayanan yang tidak tepat yang diberikan atau digunakan oleh pasien. Suatu layanan yang memenuhi

semua spesifikasi dianggap berkualitas tinggi. Kualitas harus dapat dicapai, diukur, dan menguntungkan. Dan untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras dan optimisme yang konstan. Proses peninjauan peningkatan mutu mencegah kesalahan dalam hasil evaluasi. Kualitas pelayanan keperawatan sebagai indikator perawatan medis merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan citra sosial suatu fasilitas medis. Peningkatan mutu layanan berarti penyediaan layanan yang optimal dengan mengembangkan layanan kesehatan dan keperawatan dengan standar profesional, standar layanan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, serta teknologi dan hasil penelitian yang tepat. Hal ini merupakan tingkat penyediaan layanan yang efisien dan efektif. Tingkat kesehatan tercapai. (Nugroho *et al.*, 2023)

Menurut Goeth dan Devis (1994) dalam (Surbakti, 2021) Kualitas merupakan suatu keadaan dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, produk, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan. Kualitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, yaitu aspek produk atau layanan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas manusia dan kualitas proses. Suatu perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau jasa bermutu melalui suatu proses bermutu tanpa campur tangan manusia ibarat mempekerjakan personel yang tidak berkualifikasi. Kualitas proses dan hasilnya buruk. Susilovati (2013) Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kualitas adalah keberhasilan hasil akhir suatu produk atau jasa yang dihasilkan melalui suatu proses yang memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dengan bantuan manusia dan mencapai kepuasan. . Mungkin. Suatu layanan yang memenuhi semua spesifikasi dianggap berkualitas tinggi. (Bambela and Nauri, 2021).

2. Kualitas Pelayanan

Menurut (Oentara dan Bernarto, 2022), kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi tuntutan konsumen. Sedangkan menurut (Surbakti, 2021) kualitas pelayanan merupakan unsur utama dan dasar kepuasan pelanggan yang diwujudkan dengan hasil tindakan yang dilakukan melalui testimoni dari mulut ke mulut terhadap pelayanan, seperti keluhan, rekomendasi, dan lain sebagainya berbagi, dan pengalaman layanan.

Zendrato (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu sikap konsumen yang mengacu pada perbandingan antara harapan dan persepsi terhadap kinerja aktual suatu pelayanan. Kualitas layanan adalah perbandingan antara kenyataan dan harapan. Perbedaan antara keduanya terletak pada harapan pelanggan terhadap layanan yang mereka terima.

Dari penjelasan tersebut kualitas pelayanan adalah sikap yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen, dan apakah pelayanan yang diterimanya sesuai dengan harapan pelanggan. Pada akhirnya, persepsi pelangganlah yang menentukan kualitas pelayanan. Hasil akhir. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah layanan berkualitas. Sikap konsumen mengacu pada perbandingan antara harapan tentang suatu layanan dan persepsi kinerja aktualnya.

Menurut Parasuraman, Valerie A. Zeithaml dan Leonard L. Berry (1988) dalam (Magfilo, Winati & Supriyanithi, 2023) menyatakan terdapat lima dimensi dalam kualitas pelayanan.

a. Bukti fisik.

Bukti fisik merupakan aset potensial perusahaan yang memberikan bukti atas penampilan dan kinerja sarana dan prasarana fisik perusahaan, sedangkan kondisi lingkungan sekitar memberikan bukti nyata atas jasa yang diberikan oleh pemberi jasa. menyediakan: Aset fisik suatu perusahaan adalah peralatan atau perkakas eksternal (teknologi) yang tersedia bagi karyawan.

b. Keandalan

Keandalan adalah kemampuan suatu organisasi untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan. Pelayanan harus memenuhi harapan pelanggan. Bagi setiap pelanggan, ini berarti ketepatan waktu, layanan yang sempurna dan konsisten, interaksi yang menyenangkan dan presisi tinggi.

c. Daya tanggap atau responivitas

Daya tanggap adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan kompeten sekaligus memberikan informasi yang jelas. Jika konsumen tidak memiliki alasan yang jelas, kualitas layanan akan dipersepsikan negatif.

d. Jaminan

Jaminan mengacu pada pengetahuan, kemudahan didekati, dan kemampuan karyawan suatu perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

e. Empati.

Empati berarti peduli dengan tulus, secara individual dan pribadi terhadap pelanggan Anda dan mencoba memahami keinginan dan kebutuhan mereka. Perusahaan diharapkan mengetahui dan memahami pelanggan mereka, memahami kebutuhan mereka, dan mengembangkan cara kerja yang nyaman bagi mereka.

3. Mutu Pelayanan Keperawatan

Menurut (Nursalam, 2014), mutu pelayanan perawatan merupakan suatu ukuran dimana segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan perawatan yang baik. Kualitas sangat penting untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan kepuasan kerja, memperkuat kepercayaan pasien/pelanggan, dan meningkatkan perawatan pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan. Mutu pelayanan keperawatan merupakan proses kegiatan staf keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan memelihara status biologis, psikologis, sosial dan spiritualnya. (Oentala dan Bernard, 2022).

Menurut (Nursalam, 2014), mutu pelayanan keperawatan merupakan ukuran segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang baik. Kualitas sangat penting untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan kepuasan kerja, memperkuat kepercayaan pasien/pelanggan, dan meningkatkan perawatan pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan. Mutu asuhan keperawatan mengacu pada seluruh aktivitas staf keperawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan menjaga status biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan

Menurut (Dama Yasri, 2021), faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah harapan dan persepsi pelayanan pelanggan yang terbentuk pada diri pelanggan setelah menggunakan pelayanan rumah sakit. Berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa faktor yang dapat untuk meningkatkan atau menurunkan kualitas layanan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang kemajuan organisasi. Departemen sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas layanan suatu perusahaan. Apabila SDM tidak memiliki keterampilan, kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan konsumen. Sebaliknya, apabila SDM tidak memiliki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan maka kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan konsumen dapat menurun. Tanpa adanya kompetensi dan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hal ini dapat berujung pada kemunduran... Ketika

sumber daya manusia (SDM) atau pegawai memiliki kompetensi dan pengetahuan yang tinggi, maka kualitas pelayanan akan meningkat.

b. Organisasi

Suatu organisasi adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan untuk secara kolektif mewujudkan visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai visi dan misi perusahaan diperlukan adanya kerjasama antar anggota organisasi, khususnya karyawan perusahaan yang melayani publik dan mempunyai struktur kerja yang jelas.

c. Pengukuran

Pengukuran adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, memantau keluhan, dan menentukan kepuasan pelanggan yang sebenarnya. Bila evaluasi layanan sesuai dengan harapan penyedia layanan dan harapan pelanggan, maka kualitas layanan yang diberikan dikatakan tinggi. Akan tetapi, apabila evaluasi menunjukkan adanya perbedaan antara harapan penyedia layanan dan harapan pelanggan, maka kualitas layanan akan rendah.

d. Program

Program adalah serangkaian kegiatan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini termasuk manajemen keluhan pelanggan dan alat penjualan dan administrasi.

e. Komunikasi Internal

Komunikasi dari atasan kepada anggota tertentu untuk memberikan instruksi dalam suatu organisasi layanan. Ini terdiri dari prosedur dan kebijakan perusahaan mengenai layanan pelanggan dan desain umpan balik positif dalam organisasi.

f. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang ditujukan kepada pelanggan. Ini termasuk mendidik pelanggan, mengelola harapan mereka, dan membangun citra perusahaan yang positif.

5. Standar Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Permen PANRB tentang Standar Pelayanan (No. 19 Tahun 2021), ini setidaknya mencakup hal-hal berikut:

a. Proses pelayanan, proses pelayanan yang akan dilakukan terhadap pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

b. Waktu Penyelesaian:

Waktu penyelesaian ditentukan sejak saat pengajuan hingga saat penyelesaian layanan.

c. Biaya layanan

Biaya layanan atau pola tarif, termasuk rincian sebagaimana ditentukan dalam proses penyediaan layanan.

- d. Produk layanan, barang yang dapat diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan Prasarana, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dapat memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi bagi Penyedia Layanan:
Kompetensi penyedia layanan harus ditentukan secara tepat berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

6. Kebijakan Kesehatan

Pedoman dan kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Tingkat Konstitusional UUD 1945

Pasal 28 ayat 1 UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas kesehatan jasmani dan rohani." Hak untuk hidup, tempat tinggal yang baik dan sehat, serta kesehatan yang baik juga termasuk dalam hak atas kehidupan. "Hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas perawatan medis"

b. Pedoman Sistem Hukum

1) Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Pernyataan tentang Tenaga Kesehatan secara khusus dilakukan . Layanan kesehatan dikategorikan ke dalam tingkat promosi, pencegahan, pengobatan dan kinerja perawatan kesehatan. dan layanan rehabilitasi. Undang-Undang tersebut secara khusus mengatur hak masyarakat atas kesehatan dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

2) Undang-Undang ini menetapkan kualifikasi minimum bagi pekerja perawatan kesehatan dan mekanisme untuk mengendalikannya (Pasal 21 sampai dengan 29).

3) Mengenai jaminan mutu, Undang-Undang tersebut mengharuskan pemerintah untuk menetapkan standar mutu pelayanan medis untuk memastikan praktik pelaksanaan yang aman dan melindungi keselamatan pasien (Pasal 52 hingga 55). Pasal).

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 "Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Medis Non Esensial" mengatur tentang penyelenggaraan "Jenis Pelayanan Medis Dasar" yang merupakan pelayanan pemerintah wajib yang wajib diikuti oleh seluruh

warga negara. mematuhi. Ini adalah Pasal 1.1 dari "Aturan tentang Makanan dan Kualitas Makanan." Warga negara berhak atas pelayanan non esensial, dan Pasal 1 ayat 3 UU Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar mengatur bahwa kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa untuk kebutuhan kesehatan dasar serta pemenuhannya harus ditentukan oleh teknologi, diukur secara non material berdasarkan pelayanan dasar sesuai standar internasional agar dapat hidup dengan benar dan layak

C. Teknologi Informasi

Menurut beberapa ahli, teknologi informasi adalah:

- a. Menurut O'Brien (2005; 46) (Rila, 2024), teknologi informasi adalah kombinasi antara pemrosesan data (komputer) dan jalur komunikasi berkecepatan tinggi. Mengirimkan data, suara, dan video.
- b. Menurut (Nugroho et al., 2023), teknologi informasi diartikan sebagai alat yang digunakan oleh manajer untuk mengelola perubahan yang muncul. Dalam kasus ini, informasi yang sebelumnya diproses dan disimpan di komputer Anda akan diubah.
- c. Menurut (Sofianto, 2020), teknologi informasi didefinisikan sebagai kombinasi teknologi komputer, yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memproses dan menyimpan informasi, dan teknologi komunikasi, yang memberikan informasi. Ini termasuk penggunaan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi dan pemrosesan serta penyimpanan informasi selanjutnya oleh komputer.
- d. Menurut (Sianturi, 2022), adalah tentang menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Mewakili informasi strategis.
- e. Teknologi penggunaan komputer sebagai perangkat utama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu bagaimana orang menggunakan teknologi untuk beradaptasi dengan suatu tugas. Menurut teori sikap dan perilaku, penggunaan komputer pribadi (PC) oleh pekerja yang berpendidikan dalam lingkungan pilihan (opsi) dipengaruhi oleh perasaan pribadi terhadap penggunaan PC (efek). Penggunaan komputer yang dapat diterima, norma sosial mengenai penggunaan PC di tempat kerja (norma sosial), kebiasaan mengenai penggunaan komputer (preferensi), hasil individu yang

diharapkan dari penggunaan PC (hasil), dan kondisi yang memfasilitasi (kondisi yang memfasilitasi).) dalam lingkungan yang kompatibel dengan PC (Ginting, 2020).

Menurut (Carlof dan Mulyanti, 2023), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa orang lain mendorong penggunaan teknologi informasi yang positif. Saya meyakinkannya.

2. Emosi (Afek)

Emosi pribadi mengacu pada bagaimana perasaan individu dan apakah mereka puas atau tidak dalam menyelesaikan tugas menggunakan teknologi informasi.

3. Fitur Task Fit atau kesesuaian tugas

Teknologi Informasi memberikan indikasi yang lebih tepat tentang hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan persyaratan tugas.

4. Dampak jangka panjang

Dampak jangka panjang diukur dari apakah kepergian yang dihasilkan memberikan manfaat di masa depan seperti peluang yang lebih baik untuk kemajuan karier atau posisi yang lebih tinggi.

5. Kondisi yang Memfasilitasi Penggunaan Teknologi Informasi

Kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi informasi meliputi faktor-faktor objektif dalam lingkungan kerja yang memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugasnya.

6. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat di mana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk dipahami dan digunakan.

E. Dampak Teknologi Informasi

1. Dampak Positif

Dampak positif adanya teknologi informasi adalah:

- a. Peralatan yang semakin modern dan praktis memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan.
- b. Hanya dengan menggunakan Internet, Anda dapat berkomunikasi dengan pengguna lain melalui email, obrolan, atau bahkan secara langsung.
- c. Keberadaan teknologi informasi telah menyebabkan munculnya berbagai macam jejaring sosial.

- d. Internet memudahkan kita mencari informasi tentang topik tertentu, kita dapat berbelanja di Internet, dan dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bahkan dapat mengakses Internet di ujung jari kita melalui ponsel kita.
- e. Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui email, obrolan, dan bahkan video. Web sebagai media komunikasi merupakan fitur web yang digunakan secara luas yang memungkinkan setiap pengguna web untuk berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia.
- f. Media pertukaran data memungkinkan pengguna Web di seluruh dunia untuk bertukar informasi dengan cepat dan murah. Akses mudah terhadap informasi di internet memungkinkan orang untuk tetap mendapat informasi tentang peristiwa terkini. Situs ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang pendidikan, budaya, dan lain-lain.
- g. Memfasilitasi transaksi bisnis dan penyelesaian di sektor komersial, menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke lokasi tender/penjualan.

2. Dampak Negatif

Pengenalan teknologi informasi memiliki efek negatif berikut pada kinerja karyawan:

- a. Kemalasan berasal dari godaan dan aplikasi di Internet. Sekitar tahun
- b. Informasi dapat direproduksi tanpa izin dari atau mengutip sumbernya. Ini biasanya disebut "copasto".
- c. Munculnya Konten Pornografi/Dewasa.
- d. Sosialisasi menurun karena karyawan lebih suka berkomunikasi melalui Internet daripada pertemuan tatap muka.
- e. Perubahan dalam kehidupan sosial tersebut berdampak pada perubahan pola interaksi (Putra, 2019).

F. Jenis Teknologi Informasi

Menurut O'Brien (2005; 60) (Nugroho et al., 2023), teknologi informasi meliputi:

1. Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah jaringan yang memungkinkan orang berkomunikasi jarak jauh. Telekomunikasi memudahkan pustakawan untuk terhubung dengan orang lain dan mengembangkan perpustakaan mereka. Telekomunikasi, seperti telepon dan internet.

2. Sistem kaset video

Merupakan sistem yang menyimpan informasi dalam pita yang dapat ditampilkan di layar. Sistem ini digunakan untuk merekam sumber informasi langsung seperti Handicam.

3. Videodisc

Videodisc adalah cakram yang menggunakan sinar laser untuk menyimpan data berbasis komputer seperti artikel atau manuskrip lama. Videocakram menyimpan informasi dan penting dalam melestarikan bahan perpustakaan. Contoh cakram video adalah

4. Komputer CD-ROM

Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi data secara independen dan bertindak sebagai alat untuk memproses data. Komputer ini merupakan pengenalan yang paling penting terhadap teknologi informasi karena sebagian besar teknologi informasi menggunakan komputer untuk menjalankan proses. Komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras mencakup perangkat masukan data (pendukung, penyaliran), unit pemrosesan informasi (CPU), perangkat tampilan keluaran data (layar/monitor, printer), dan perangkat penyimpanan data (floppy disk, hard disk, CD). Termasuk: perangkat lunak mencakup perangkat lunak penghitungan numerik, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah gambar, dan perangkat lunak presentasi media cerdas.

5. Microform

Microform adalah suatu alat yang menyimpan informasi dalam bentuk mikro yang berupa teks, gambar, atau grafik yang disusun secara horizontal atau vertikal pada selebar film. Mikrofilm sering digunakan untuk merekam naskah-naskah lama dan memerlukan alat pembaca khusus, yaitu Reider skala 6.9 kecil, untuk membacanya.

6. Komunikasi suara berbantuan komputer

Dapat menghubungkan komputer di satu lokasi atau di seluruh dunia.

7. E-mail

E-mail merupakan salah satu cara pencatatan pesan komersial dan pengiriman pesan antar tempat kerja. E-mail memungkinkan klien komputer untuk bertukar pesan dengan klien lain melalui jaringan komunikasi.

8. Videoteks dan Teleteks

Videoteks mengirimkan pesan dalam bentuk suara, teks dan gambar. Ini adalah transmisi informasi yang dikodekan komputer sebagai bagian dari sinyal televisi untuk tujuan menampilkan gambar dan teks. Di sisi lain, Teletext adalah bagian dari Videotext dan mengirimkan pesan hanya dalam bentuk teks

G. Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keperawatan

Menurut (Sari Dian Kumala, Bintaria Ayu Purwandrari, 2023), teknologi 5.0 di era ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor karena

hadirnya aplikasi klinis yang membantu peningkatan pelayanan perawatan dan kesehatan secara keseluruhan. Peran teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan klinis dan memungkinkan organisasi layanan kesehatan mengelola keputusan secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan: Contoh:

1. Mengurangi waktu tunggu Klinik

Kehadiran aplikasi juga memudahkan dan menghemat waktu akses untuk layanan medis bagi pasien. Daripada menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan medis, pasien dapat memesan janji temu secara online dan menunggu di poliklinik sesuai dengan antrian yang ditentukan.

2. Penyimpanan Data yang Aman

File digital, salinan rahasia semua dokumen dapat disimpan. Tidak perlu menyediakan ruang penyimpanan, rak, atau organizer untuk menyimpan berkas. Data penting seperti rekam medis, identitas pasien, dan data lainnya disimpan dalam sistem. Dengan cara ini, data tidak dapat mudah rusak atau hilang karena akses hanya dibatasi pada mereka yang terlibat.

3. Menyediakan perawatan kesehatan kepada lebih banyak pasien

Kemajuan teknologi memungkinkan penyediaan perawatan kesehatan kepada pasien di wilayah geografis yang lebih luas. Layanan perawatan kesehatan disediakan melalui iklan daring, sehingga jangkauannya tidak terbatas pada satu lokasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan pasien sebagai responden utama. Misalnya, memiliki keberanian untuk merefleksikan layanan medis yang telah Anda berikan, mendapatkan umpan balik, dan meningkatkan kualitas pekerjaan Anda. Jika pelayanan medis dikelola dengan baik, pasien baru akan tetap setia pada klinik dan mencari pengobatan. Selain memberikan informasi tentang layanan medis, Anda juga dapat menyediakan konten pendidikan kesehatan untuk menarik pasien baru.

4. Rekam Medis Terpadu

Rekam medis merupakan dokumen penting bagi tenaga kesehatan dan pasien. Data ini memungkinkan staf medis untuk memberikan intervensi klinis yang tepat, cepat dan akurat. Pemerintah sendiri telah memperkenalkan Peraturan Catatan Pasien Elektronik sebagai standar nasional dalam sistem perawatan kesehatan. Pasien dapat mengakses catatan medis mereka dari mana saja. Kemampuan untuk mengunduh dokumen medis berarti pasien tidak perlu lagi mengambil hasil tes secara langsung dari klinik.

5. Ketersediaan Pelayanan Pembelian Obat

Penggunaan obat merupakan kebutuhan dasar di fasilitas kesehatan. Selain berkonsultasi dengan tenaga medis profesional, Anda juga harus

mengonsumsi obat untuk mencegah penyakit bertambah parah dan mempercepat pemulihan. Oleh karena itu, kerja sama antara produsen farmasi dan klinik diperlukan untuk memastikan pasokan obat dalam jangka panjang. Teknologi memainkan peran penting dalam memastikan inventaris obat dan melakukan pemesanan dengan aman. Apalagi berkat transaksi online yang cepat, obat-obatan yang dipesan langsung diantar ke klinik dalam waktu yang sangat singkat.

6. Kemudahan Akses Informasi

Kemampuan teknologi informasi membuat pemrosesan data dan akses informasi menjadi jauh lebih mudah. Teknologi memungkinkan data digunakan sesuai kebutuhan, seperti mengevaluasi kinerja pasien, merekam catatan medis, dan mengakses riwayat medis pasien.

7. Sarana komunikasi antar tenaga medis

Komunikasi antar tenaga medis juga harus dijaga untuk menghindari kesalahan dalam prosedur medis. Fungsi teknologi adalah untuk mempercepat komunikasi antara profesional medis. Kehadiran aplikasi klinis gratis menciptakan sistem terpadu yang memungkinkan para profesional medis untuk mengirimkan dokumentasi terkait pasien secara lebih efisien. Dokter dapat membuat keputusan lebih cepat.

8. Komputerisasi Pelayanan Konsultasi Dokter

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 menegaskan peran dokter sangat krusial. Dokter menawarkan layanan konsultasi, termasuk meresepkan obat, yang juga dapat dilakukan secara daring. Sistem konsultasi medis daring ini disebut telemedicine, dan memungkinkan pasien menerima layanan medis tanpa harus datang ke klinik.

9. Mengurangi Kesalahan dalam Prosedur Medik

Kesalahan dalam prosedur medis dapat menimbulkan konsekuensi yang berbahaya bagi pasien. Menurut Starfield dan Institute of Medicine (IOM), 98.000 orang meninggal setiap tahun di rumah sakit dan fasilitas kesehatan akibat kesalahan medis. Aplikasi klinis dapat mengurangi kesalahan medis dan membantu lebih banyak pasien. Informasi selalu diberikan secara jujur dan tepat waktu untuk membantu dokter memberikan perawatan tepat waktu.

10. Rekomendasi Aplikasi Klinik

Untuk mempercepat adopsi rekam medis elektronik dalam layanan kesehatan di Indonesia, Aplikasi Klinik Pintar menawarkan program penggunaan aplikasi gratis hingga Desember 2024. Program ini bertujuan agar mitra terbiasa menggunakan EMR pada bulan Desember 2023.

H. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Menurut (Adolph, 2016) menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan seperti :

1. Aksesibilitas yang Menjadi Tantangan Utama

Isu sentral dalam layanan kesehatan yang semakin mendapat sorotan adalah masalah aksesibilitas. Terutama di daerah pedesaan atau terpencil, tantangan dalam mencapai fasilitas kesehatan berkualitas masih menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Infrastruktur yang terbatas, kekurangan tenaga kesehatan, dan perawatan medis yang tidak memadai tetap menjadi kendala utama yang harus diatasi. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mampu mengakomodasi berbagai aspek. Pengembangan pusat kesehatan komunitas dapat menjadi solusi dengan mendekatkan layanan medis ke masyarakat, sementara pemanfaatan layanan telemedicine dapat mengatasi hambatan jarak dan memperluas cakupan layanan.

Melalui sinergi antara pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia di bidang medis, dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, diharapkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dapat meningkat secara signifikan, bahkan di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

2. Revitalisasi Teknologi dalam Layanan Kesehatan

Walaupun kontribusi teknologi dalam perkembangan layanan kesehatan sangat besar, perlu diakui bahwa penerapan teknologi medis tidak datang tanpa rintangan. Meskipun potensinya besar, Masih banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah buruknya integrasi ke dalam sistem manajemen informasi kesehatan. Data medis yang tersebar di berbagai platform bisa menghambat efisiensi dan kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan. Selain itu, kekhawatiran akan privasi data pasien menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Penggunaan teknologi medis seringkali melibatkan pengumpulan dan penyimpanan informasi sensitif, yang mengharuskan adanya langkah-langkah yang tegas dalam melindungi informasi tersebut dari akses yang tidak sah.

Tidak semua orang juga memiliki akses yang sama terhadap teknologi medis. Kesenjangan akses dapat membatasi potensi teknologi dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik. Pelatihan tenaga medis dalam pemanfaatan teknologi medis menjadi esensial.

Tenaga medis yang terampil dalam mengoperasikan dan memahami teknologi medis akan mampu memaksimalkan manfaatnya dan menjembatani kesenjangan pengetahuan. Di samping itu, penguatan regulasi yang berkaitan dengan keamanan data pasien perlu ditingkatkan. Regulasi yang kuat akan memberikan kepercayaan kepada pasien bahwa informasi medis mereka akan dijaga secara ketat.

Keseluruhan, untuk mengadopsi teknologi medis secara efektif, perlu ada kerja sama lintas sektor, termasuk penyedia layanan kesehatan, pemerintah, dan lembaga regulasi. Dengan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan melindungi privasi pasien serta keamanan informasi, maka potensi teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dapat direalisasikan dengan lebih baik.

3. Kompleksitas Tantangan Finansial

Hadirnya biaya perawatan kesehatan seringkali memberikan beban finansial yang luar biasa bagi individu dan keluarga. Masalah ini semakin pelik akibat minimnya perlindungan dari asuransi kesehatan yang memadai. Di banyak tempat, terdapat kelompok masyarakat yang masih belum mendapatkan akses penuh terhadap perlindungan kesehatan yang layak. Akibatnya, mereka sering kali terpaksa menunda perawatan yang seharusnya mendesak atau mencari alternatif yang mungkin kurang efektif atau kuratif karena pertimbangan finansial.

Untuk mengatasi tantangan yang mengancam kesejahteraan ini, diperlukan upaya konkret dalam meningkatkan akses terhadap asuransi kesehatan yang terjangkau. Langkah ini akan memberikan perlindungan finansial yang penting bagi individu dan keluarga ketika mereka menghadapi masalah kesehatan yang tak terduga.

Dikutip dari [katadata.com](https://katadata.id) bahwa penduduk Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan dari tahun ketahun terus meningkat meskipun tidak signifikan. Ditahun 2022 menunjukkan 62,69% penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menjadi langkah baik untuk terus meningkatkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Meskipun masih terdapat 37,31% penduduk Indonesia yang perlu diperhatikan.

Selain jaminan kesehatan, pengembangan program-program bantuan biaya medis juga menjadi langkah penting dalam merespons masalah ini. Program ini bisa berupa subsidi pemerintah, bantuan dari lembaga amal, atau kemitraan antara sektor swasta dan publik untuk memberikan akses terhadap perawatan medis berkualitas tanpa membebani finansial.

Namun, tidak hanya cukup dengan akses terhadap perlindungan kesehatan dan program bantuan biaya medis. Edukasi juga memegang peran penting dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu lebih menyadari pentingnya asuransi kesehatan dan manfaat perawatan medis yang tepat waktu. Selain itu, pemerintah dan organisasi kesehatan dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong partisipasi yang lebih luas dalam asuransi kesehatan, termasuk di kalangan mereka yang berpenghasilan rendah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, langkah-langkah ini dapat menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih kuat dalam menghadapi beban keuangan biaya perawatan kesehatan.

4. Transformasi Demografi dan Dinamika Penyakit

Semakin bertambahnya jumlah lansia dalam populasi, tuntutan akan pendekatan perawatan yang lebih spesifik dan holistik semakin mendesak. Kondisi kesehatan dan kebutuhan medis yang berbeda pada tahapan kehidupan yang berbeda perlu diperhitungkan secara cermat agar kualitas hidup para lansia dapat dijaga dengan baik. Selain itu, peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan obesitas juga mendorong perubahan dalam sistem perawatan kesehatan. Selain memberikan perawatan yang tepat, pendekatan pencegahan yang lebih holistik menjadi semakin penting. Langkah-langkah yang mengedepankan pendidikan masyarakat mengenai gaya hidup sehat dan strategi pencegahan penyakit perlu diintegrasikan dalam sistem kesehatan. Melalui upaya edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih sadar akan risiko penyakit serta dampak dari gaya hidup tertentu, dan mereka dapat mengambil tindakan proaktif dalam menjaga kesehatan mereka.

Dengan menyatukan kekuatan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit, dampak positifnya dapat membentuk budaya kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi teknologi informasi dan media sosial dalam kampanye edukasi juga dapat memperluas jangkauan pesan-pesan kesehatan ini. Keseluruhan, pengelolaan perubahan demografis dan dinamika penyakit memerlukan pendekatan yang responsif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi, serta merangkul inovasi dalam pencegahan dan perawatan, mengatasi tantangan-tantangan ini akan membantu membangun komunitas yang lebih sehat dan kuat.

5. Keberlanjutan Tenaga Medis

Kekurangan tenaga medis yang mencakup dokter, perawat, dan anggota staf medis lainnya, menjadi tantangan krusial yang merentang di berbagai

sistem pelayanan kesehatan. Kondisi ini sering kali berdampak pada antrian panjang, penurunan mutu perawatan, dan peningkatan beban kerja yang tak terelakkan bagi para profesional medis yang sudah ada.

Permasalahan ini juga menyoroti pentingnya distribusi yang merata dan efisien dari tenaga medis di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil yang seringkali kesulitan untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya pendekatan terintegrasi. Salah satunya adalah peningkatan pendidikan medis secara keseluruhan. Melalui pembelajaran yang komprehensif dan terkini, para calon tenaga medis akan lebih siap menghadapi kompleksitas dunia kesehatan. Di samping itu, insentif yang signifikan dapat mendorong para profesional medis untuk mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil. Ini bisa berupa fasilitas kesehatan yang lebih baik, tunjangan, atau program pelatihan lanjutan.

Selain itu, penting juga untuk menginspirasi generasi muda agar tertarik untuk mengejar karir di bidang kesehatan. Kampanye yang menjelaskan betapa pentingnya peran para profesional medis dalam masyarakat, serta menyediakan akses yang lebih mudah ke pendidikan medis, dapat mendorong lebih banyak individu untuk mengambil jalur ini sebagai karir. Pengembangan program pengenalan dunia medis sejak dini di sekolah juga dapat membangkitkan minat anak muda dalam bidang ini.

Keseluruhan, mengatasi kelangkaan tenaga medis memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga kesehatan. Dengan menerapkan solusi yang beragam, mulai dari peningkatan pendidikan, insentif bagi profesional medis, hingga upaya untuk memotivasi generasi muda, diharapkan kelangkaan tenaga medis dapat diatasi secara berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

I. Kesimpulan

Penggunaan sistem manajemen teknologi informasi di sektor kesehatan, terutama sektor keperawatan, telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan sektor pelayanan kesehatan. Dampak positifnya juga dirasakan oleh penerima layanan, yaitu layanan masyarakat dan perawatan. Penyedia. Pada akhirnya, penggunaan sistem teknologi informasi di sektor perawatan keperawatan dapat berkontribusi dalam peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan sekaligus menjamin keselamatan pasien selama perawatan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan berkontribusi terhadap efektivitas layanan perawatan kesehatan. Namun, ada banyak kendala dan keterbatasan dalam penerapan teknologi ini dalam layanan, termasuk faktor manusia, keuangan, politik, dan keamanan. Mengingat perkembangan teknologi informasi dan layanan kesehatan saat ini, hal ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada pekerja dan fasilitas perawatan kesehatan. Profesional perawatan kesehatan diharapkan menyadari pentingnya penerapan teknologi dalam layanan kesehatan dan tertarik mempelajari cara menggunakannya. Tidak mudah bagi institusi medis untuk mengadopsi teknologi perawatan kesehatan, tetapi melihat tuntutan zaman dan berbagai manfaat yang menyertainya, ada baiknya untuk mencobanya. Administrator layanan kesehatan harus membentuk kelompok adopsi teknologi khusus untuk mempersiapkan organisasi layanan kesehatan mereka dalam penerapan pengembangan teknologi.

Tantangan-tantangan yang ada dibalik layanan kesehatan menjangkau berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas hingga transformasi demografi. Meskipun rumit, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan upaya bersama antara pemerintah, industri, serta masyarakat. Melalui inovasi teknologi, perluasan akses terhadap perawatan kesehatan, dan fokus pada pendekatan pencegahan, layanan kesehatan dapat bertransformasi menjadi lebih inklusif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan lebih baik.

Tantangan-tantangan di balik layanan kesehatan menjangkau berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas hingga transformasi demografi. Meskipun rumit, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan upaya bersama antara pemerintah, industri, serta masyarakat. Melalui inovasi teknologi, perluasan akses terhadap perawatan kesehatan, dan fokus pada pendekatan pencegahan, layanan kesehatan dapat bertransformasi menjadi lebih inklusif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan lebih baik.

- a. Sistem informasi adalah sistem yang menggunakan berbagai teknologi dalam suatu kerangka kerja untuk menghasilkan informasi yang berguna.
- b. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer.
- c. Karena pengaruh teknologi informasi, perawat sebagai penyedia layanan kesehatan harus mampu lebih mengembangkan teknologi informasi dalam keperawatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Sistem perawatan kesehatan Indonesia saat ini tertinggal dari negara lain, dan pemerintah kurang memperhatikan standar fasilitas kesehatan dalam hal dampaknya terhadap hasil pasien.

Inovasi dalam perawatan kesehatan juga diperlukan untuk memperbaiki sistem. Ini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan komputer sebagai perantara dalam jaringan kerja (organisasi). Jaringan adalah sistem yang memungkinkan informasi atau pesan dikirim dan diterima melalui kabel. Teknologi sistem informasi memungkinkan adanya pengendalian.

J. Referensi

- Adolph, R. (2016) 'Masalah pelayanan Kesehatan di Indonesia Menurut Kemenkes', *Teramedik.com*, pp. 1–23.
- Bambela, I.D.N. and Nauri, A.T. (2021) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit: Literature Review', *Journal of Hospital Management*, 4(02, September 2021), pp. 61–65.
- Carlof and Mulyanti, D. (2023) 'Inovasi Teknologi dalam Manajemen Kesehatan: Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Elektronik di Rumah Sakit', *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS) Vol. 2, No. 2 Mei 2023*, 2(2), pp. 50–62.
- Dama yasri (2021) 'Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien di Puskesmas Latong Kabupaten Padang Lawas'.
- Fadhila, R. and Afriani, T. (2019) 'PENERAPAN TELNURSING DALAM PELAYANAN KESEHATAN: Literature Review', *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 3(2), pp. 77–84. Available at: <https://doi.org/10.36341/jka.v3i2.837>.
- Ginting, D.S. (2020) 'Pemanfaatan teknologi kesehatan dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan.', *Kajian Ilmiah*, p. 10.
- Humam, K. (2021) 'Gambaran Kesiapan Perawat Ruang Rawat Inap Terhadap Implementasi Telenursing Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Di RSUD Gondo Suwarno Kabupaten Semarang', p. 6.
- Laila (2024) 'Teknologi Informasi: Defenisi, Fungsi, Manfaat dan Tantangannya', *Gramedia Blog*, pp. 1–20. Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/teknologi-informasi/?srsltid=Af>.
- Magfiroh, N.A., Winarti, R. and Supriyanti, E. (2023) 'Hubungan Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang Baitul Izzah I RSI Sultan Agung', *Journal Of Nursing & Health*, 8(2), pp. 151–162.
- No.19, P.R. (2021) 'Permen PANRB No. 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan KEMENPANRB', (3), pp. 1–124.
- Nugroho, R. *et al.* (2023) 'Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis Kebijakan', *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), pp. 277–285. Available at: <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.28550>.

- Nurnainah, Novian Aldo, A.I.K. dll (2024) 'Pengaruh Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keperawatan: Analisis Pengalaman Praktisi Bisnis Keperawatan', *Jurnal Review ...*, 7, pp. 1032–1051. Available at: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/24938>
- Nursalam (2014) 'Manajemen keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional', p. 117.
- Oentara, S. and Bernarto, I. (2022) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pasien dengan Kepuasan Pasien sebagai Mediasi di WellClinic Gading Serpong [The Effect of Service Quality on Patient Loyalty Mediated by Patient Satisfaction in WellClinic Gading Serpong]', *Indonesian Marketing Journal*, 2(1), p. 131. Available at: <https://doi.org/10.19166/imj.v2i1.5866>.
- Putra, C.S. (2019) 'Peranan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit', *Simtika*, 2(3), pp. 28–31.
- Sari Dian Kumala, Bintaria Ayu Purwandrari, D. (2023) 'Peranan Telenursing Untuk Meningkatkan Mutu dalam Pelayanan Keperawatan', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.33560/jmiki.v11i1.408>.
- Sianturi, S.R. (2022) 'Upaya Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Teknologi Informasi Dalam Keperawatan', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan (Abdimakes)*, 2(1), pp. 51–57. Available at: <https://doi.org/10.55316/amk.v2i1.771>.
- Sofianto, A. (2020) 'Services Innovation Based On Information Technology In Hospital As a Form Bureaucratic Reform', *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(1), pp. 81–102.
- Surbakti, L. (2021) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Perawat Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD. Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai', *Skripsi*, pp. 1–102.
- Susilowati, L. (2013) *Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Berbasis Teori Juse Di Ruang Rawat Inap Bedah Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Skripsi Universitas Airlangga*.
- Zendrato, M.L.V. (2022) 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan Menggunakan Personal Digital Assistant (Pda): Literatur Review', *Jurnal Ilmiah Permas*, 12(3), pp. 719–724. Available at: <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>.
- Zuliatika, P. and Purnamawati, D. (2024) 'Peran Telenursing dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan', *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(1), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v3i1.574>.

K. Glosarium

CPU	Unit Pemrosesan Pusat adalah sirkuit elektronik didalam komputer yang menjalankan perintah untuk memprogram komputer
EMR	Elektronik Medical Record adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk merekam, menyimpan dan mengelola informasi medis pasien secara elektronik dalam format digital yang dapat dibagikan keberbagai rangkaian layanan kesehatan
FLOPPY DISK	Diket atau cakram liuk adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan lentur, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang
MICROFORM	Adalah bentuk film atau kertas yang berisikan mikroreproduksi dari dokumen untuk pengiriman, penyimpanan, pembacaan atau pencetakan. Gambar dalam mikroform umumnya diperkecil sekitar 25 kali ukuran aslinya
MIKROFILM	Sering disebut Mikrofotografi, merupakan teknik pengurangan sebuah gambar menjadi lebih kecil dimana gambar tersebut tidak dapat dibaca tanpa alat bantu
PC	Personal Computer adalah perangkat komputer yang dirancang untuk penggunaan individu
SIMPUS	Software Sistem Informasi Puskesmas merupakan software yang ditujukan untuk mengelola aktivitas keseharian Puskesmas mulai dari pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap palaporan data
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat
TELECARE	Penggunaan teknologi komunikasi untuk menyediakan dukungan perawatan jarak jauh
TELETEKS	Sistem penyampaian informasi satu arah yang sistem pemancarannya dengan memanfaatkan garis televisi yang tidak dimanfaatkan dalam pengiriman sinyal gambar dan sinyal suara
VIDEOTEKS	Pelayanan informasi interaktif dari komputer pusat yang memungkinkan individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau

kabel, untuk ditampilkan ada layar tampilan video.

CHAPTER 5

MANAJEMEN WAKTU DALAM KEPERAWATAN: TEKNIK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI LAYANAN

Novita Verayanti Manalu, S.Kp., Ns., MAN.

A. Pendahuluan

Manajer memiliki empat jenis sumber daya: manusia, peralatan, uang, dan waktu (Manalu, 2023). Dari keempat sumber daya tersebut, waktu tidak dapat tergantikan, yang berarti keterampilan manajemen waktu sangat penting untuk meraih kesuksesan (Mandias et al., 2021). Keperawatan merupakan karir yang sangat dibutuhkan. Dalam pekerjaan keperawatan, perawat tidak hanya memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi juga dipaksa untuk membuat beberapa keputusan. Untuk itulah pentingnya manajemen waktu dimulai.

Manajemen waktu adalah metode yang digunakan untuk mengatur waktu kita, sehingga setiap keputusan yang kita buat mengenai hal tersebut berguna, konstruktif, dan paling bermanfaat bagi struktur kehidupan kita. "Itu merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk keberhasilan manajer dan salah satu strategi untuk meningkatkan kondisi kelangsungan hidup organisasi, dapat dibangun dalam suatu organisasi dengan sukses jika latar belakang budaya yang sesuai telah ditetapkan untuk sistem ini" (Davies et al., 2019).

Manajemen waktu dalam keperawatan merupakan aspek krusial yang berperan dalam meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas perawatan pasien. Dalam konteks keperawatan, manajemen waktu tidak hanya sekadar pengaturan jadwal, tetapi juga mencakup kemampuan perawat untuk merencanakan, mengorganisir, dan memprioritaskan tugas-tugas mereka (Taylor & Damewood, 1992). Dengan tuntutan yang tinggi dan beban kerja yang sering kali padat, perawat dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab dalam waktu yang terbatas. Oleh karena itu, penguasaan teknik manajemen waktu yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan yang tepat dan berkualitas (Dolu & Nahcivan, 2019).

Keberhasilan manajemen waktu dalam keperawatan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan kepuasan pasien, pengurangan kesalahan medis, dan peningkatan produktivitas perawat (Manalu, Mukhoirotin, et al., 2021). Perawat yang mampu mengelola waktu dengan baik dapat lebih fokus pada kebutuhan pasien, sehingga meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan keperawatan. Selain itu, manajemen waktu yang baik juga berkontribusi pada kesehatan mental perawat itu sendiri,

mengurangi stres akibat beban kerja yang berlebihan dan membantu mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional (Dolu & Nahcivan, 2019).

B. Keuntungan Manajemen Waktu dalam Keperawatan

Manajemen waktu perawat tidak hanya mempengaruhi kemampuan perawat untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Manajemen waktu juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, kemajuan profesional, dan kolaborasi yang sukses dengan penyedia layanan kesehatan lainnya (Mandias et al., 2021). Berikut ini adalah beberapa keuntungan penting lainnya dari manajemen waktu perawat yang efektif:

1. Mengurangi Kesenjangan Perawatan Pasien.

Seperti yang disebutkan di atas, kekurangan perawat telah mengakibatkan kesenjangan perawatan pasien. Dengan perawat yang sering menghadapi rasio perawat-pasien yang kurang ideal, beberapa pasien akhirnya menerima perawatan yang tidak sesuai dengan praktik terbaik. Gangguan dalam perawatan ini dapat meningkatkan risiko hasil kesehatan yang merugikan bagi pasien (Laing & Smythe, 2025).

Keterbatasan waktu sering kali berkontribusi pada kesenjangan dalam perawatan, dan dengan lebih sedikit perawat yang bertugas, masing-masing perawat memiliki lebih sedikit waktu daripada sebelumnya (O'mahony et al., 2021). Akibatnya, perawat mungkin kesulitan menemukan waktu untuk membahas perawatan pencegahan secara menyeluruh dengan pasien mereka, misalnya, atau menjelaskan diagnosis secara memadai. Hal ini dapat mengakibatkan pasien tidak mendapatkan pemeriksaan kolorektal yang diperlukan atau mammogram yang direkomendasikan.

Namun, keterampilan manajemen waktu yang tajam dapat membantu perawat mencegah kelalaian dalam perawatan tersebut. Dengan mendefinisikan ulang cara mereka bekerja dan mengadopsi kebiasaan yang meningkatkan efisiensi mereka, perawat dapat menciptakan lebih banyak waktu dalam jadwal mereka, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam praktik terbaik yang mengendalikan kesenjangan perawatan.

2. Meningkatkan Efisiensi Layanan Perawatan Pasien.

Manajemen waktu dapat mengurangi kecemasan yang dialami perawat selama melakukan pekerjaan mereka. Ini membantu perawat mengatur emosi mereka dan mengatasi situasi yang menantang dengan lebih baik saat situasi tersebut muncul (Clarke et al., 2025). Ini juga dapat menghasilkan:

- a. Lebih sedikit kesalahan dalam layanan perawatan
- b. Peningkatan komunikasi dengan rekan kerja dan pasien
- c. Peningkatan analisis data dalam pengambilan keputusan
- d. Peningkatan dalam manajemen operasional dan fasilitas

Perawat berfungsi sebagai penyedia perawatan utama di rumah sakit dan memberikan sebagian besar perawatan jangka panjang (P. D. Wilson et al., 2013). Mereka juga merupakan bagian terbesar dari pekerja perawatan kesehatan. Tidak dapat dihindari, mereka memiliki dampak besar pada cara organisasi perawatan kesehatan beroperasi.

Praktik keperawatan dapat mempengaruhi efisiensi operasional sehari-hari di fasilitas medis mana pun. Misalnya, praktik keperawatan dapat mempengaruhi waktu tunggu pasien, biaya operasional, dan penggunaan sumber daya (Soliman, 1997). Jika demikian halnya, manajemen waktu perawat yang efektif dapat:

- a. Menghemat biaya perawatan
- b. Meningkatkan kepuasan pasien
- c. Membantu mengurangi pemborosan penggunaan peralatan
- d. Potensi peningkatan hasil perawatan pasien

Organisasi perawatan kesehatan memiliki sejumlah cara untuk meningkatkan pelayanan pasien mereka — misalnya, dengan meningkatkan efisiensi operasional fasilitas, melakukan upaya untuk menjaga kepuasan pasien, dan menyediakan perawatan berkualitas tinggi secara konsisten, untuk menyebutkan beberapa di antaranya (Manalu, Masruroh, et al., 2021). Peran utama perawat dalam perawatan kesehatan berarti mereka dapat membuat perbedaan besar di setiap area ini.

Dari mencegah kesalahan medis hingga menerapkan perawatan berbasis bukti, dengan keterampilan manajemen waktu yang tepat, perawat membantu memastikan bahwa organisasi mereka memberikan hasil pasien yang optimal.

C. Keterampilan Manajemen Waktu Perawat

Mengembangkan keterampilan utama tertentu dapat berdampak signifikan pada kemampuan perawat untuk mengelola waktu mereka dengan sukses. Menerapkan keterampilan ini juga dapat meningkatkan efisiensi perawat (Davies et al., 2019) dalam melakukan sejumlah tugas, antara lain:

1. Delegasi

Mengetahui cara mendelegasikan tugas membantu perawat mengelola beban kerja mereka. Delegasi yang efektif memungkinkan perawat untuk fokus pada tugas yang membutuhkan pengetahuan klinis spesifik mereka dan menugaskan tanggung jawab yang tidak terlalu rumit kepada orang lain (Manalu, Mukhoirotin, et al., 2021).

Penting bagi kerja sama tim, delegasi membantu perawat memastikan tugas yang tepat diselesaikan oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Menyerahkan tanggung jawab kepada asisten perawat atau profesional perawatan kesehatan lainnya dapat memungkinkan perawat untuk menangani tugas yang membutuhkan perhatian segera tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak terlalu mendesak.

Hal ini dapat mencegah potensi keterlambatan dalam penyelesaian tugas yang tidak terlalu mendesak, yang sering kali menyebabkan penumpukan tugas yang dapat menghambat alur kerja dan memperlambat segalanya. *The National Council of State Boards of Nursing (NCSBN)* Amerika merekomendasikan agar perawat mengingat lima hak delegasi saat mengalokasikan tugas kepada orang lain (Love et al., 2012). Hak-hak ini adalah:

a. Tugas yang Tepat

Pertimbangkan apakah tugas yang didelegasikan termasuk dalam lingkup praktik dan deskripsi pekerjaan rekan kerja. Kemudian, pastikan tugas tersebut sesuai dengan rencana perawatan pasien.

b. Keadaan yang Tepat

Delegasikan tugas hanya kepada pasien yang kondisinya stabil dan yang statusnya tidak memerlukan tindakan pencegahan keselamatan tambahan. Ini melindungi pasien dari risiko yang tidak perlu.

c. Orang yang Tepat

Pastikan untuk mendelegasikan tugas hanya kepada individu yang telah menunjukkan kapasitas mereka untuk melakukan tugas tersebut. Siapa pun yang melakukan tugas tersebut harus memiliki pelatihan, pendidikan, dan keahlian yang tepat.

d. Arah dan Komunikasi yang Tepat

Berikan instruksi yang jelas untuk tugas tersebut kepada orang yang telah didelegasikan, konfirmasi pemahaman mereka, dan jawab pertanyaan apa pun yang mereka miliki tentang apa yang dimaksud dengan tugas tersebut. Harapan untuk tugas tersebut juga harus jelas.

e. Pengawasan dan Evaluasi yang Tepat

Siap untuk mengawasi tugas yang didelegasikan bila diperlukan. Tawarkan dukungan dan umpan balik untuk memastikan pekerjaan tersebut mematuhi standar perawatan dan prosedur yang tepat.

2. Komunikasi

Komunikasi yang baik merupakan aspek penting dalam keperawatan. Komunikasi yang baik memungkinkan perawat untuk menyampaikan informasi penting tentang diagnosis, gejala, dan pilihan pengobatan kepada pasien,

keluarga mereka, dan penyedia layanan kesehatan lainnya (Manalu et al., 2020). Komunikasi yang baik juga memungkinkan perawat untuk memberikan dukungan emosional kepada mereka yang dirawat dan dukungan klinis kepada mereka yang bekerja bersama mereka.

Komunikasi yang efektif juga merupakan keterampilan penting dalam manajemen waktu perawat. Pertama, komunikasi yang baik membantu membatasi kesalahpahaman yang dapat mengharuskan anggota tim untuk membatalkan dan mengulang tugas. Dengan berkomunikasi secara jelas dengan pasien, yang juga melibatkan mendengarkan secara aktif, perawat memahami detail-detail kecil yang dapat membantu mereka memahami dan kemudian memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih cepat.

Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan perawat untuk bekerja lebih produktif. Daripada harus menghabiskan waktu untuk menjernihkan kebingungan tentang pendelegasian tugas, gejala pasien, instruksi tindak lanjut, dan pengobatan — yang semuanya dapat menyebabkan hasil pasien yang buruk dan pasien harus dirawat kembali — perawat dapat fokus pada pelaksanaan penilaian, penerapan rencana perawatan, dan penyelesaian pencatatan harian.

3. Pemikiran Kritis/critical Thinking

Perawat dengan keterampilan berpikir kritis yang baik dapat menganalisis kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan dengan lebih baik (Foy & Earls, 2005). Mereka juga dapat mengantisipasi hasil dan risiko terkait dari kondisi dan perawatan tersebut dengan lebih akurat. Hal ini memberi mereka pemahaman yang lebih tepat dan lengkap tentang situasi pasien mereka. Pada gilirannya, para perawat ini memiliki penilaian yang lebih tajam. Mereka kemudian dapat bertindak lebih cepat untuk melaksanakan intervensi berbasis bukti jika diperlukan (Jainurakhma et al., 2021).

Perawat analitis mendeteksi masalah sejak dini dan berpikir sendiri. Daripada mengikuti perintah secara membabi buta, mereka mengevaluasi setiap situasi untuk menentukan tindakan yang tepat. Misalnya, setelah melihat bahwa tekanan darah pasien telah turun di bawah tingkat yang dapat diterima, seorang pemikir kritis yang kuat tidak akan begitu saja memberikan obat tekanan darah yang diresepkan kepada pasien. Sebaliknya, mereka akan berkonsultasi dengan dokter pasien tentang cara menghentikan tekanan darah pasien agar tidak turun lebih jauh.

D. Keterampilan Manajemen Waktu Utama untuk Mahasiswa Keperawatan

Jadi, apa saja yang termasuk dalam manajemen waktu untuk mahasiswa keperawatan? Selain cukup tidur dan menyiapkan rutinitas belajar yang disiplin, mahasiswa keperawatan dapat memperoleh manfaat dari fokus pada keterampilan manajemen waktu yang khusus untuk bidang keperawatan (Kim & Shin, 2025).

1. Pelajari Strategi Prioritas di Sekolah Keperawatan

Seperti yang telah dibahas, prioritas merupakan bagian penting dari praktik keperawatan yang efektif. Mengidentifikasi secara akurat tugas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mengapa tidak hanya menghemat kerepotan tambahan bagi perawat. Dalam keperawatan, hal itu dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati.

Di sekolah keperawatan, penentuan prioritas dapat memudahkan mahasiswa untuk memenuhi tenggang waktu dan mengatur waktu mereka secara efektif (Mtiraoui et al., 2025). Hal ini, pada gilirannya, dapat meringankan sebagian tekanan yang dirasakan mahasiswa keperawatan.

Untuk mempertajam keterampilan penentuan prioritas mereka, mahasiswa keperawatan mungkin ingin memeriksa bagaimana perawat di lapangan mendekati penentuan prioritas (Mtiraoui et al., 2025). Saat merencanakan pekerjaan mereka, perawat yang secara efektif memprioritaskan tugas mereka mengajukan serangkaian pertanyaan kepada diri mereka sendiri:

- a. Item penting apa yang bergantung pada penyelesaian tindakan spesifik?
- b. Tugas apa yang sensitif terhadap waktu?
- c. Apa yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Mahasiswa keperawatan dapat menerapkan pertanyaan panduan yang sama ini pada pekerjaan mereka sendiri. Ini dapat membantu mereka mengatur daftar tugas, mengalokasikan waktu mereka dengan tepat, dan mewujudkan tujuan akademis mereka.

2. Bangun Kepercayaan Diri yang Dibutuhkan untuk Pendelegasian

Merasa nyaman dalam mendelegasikan tugas membutuhkan banyak kepercayaan diri, tetapi itu adalah kunci untuk kerja tim yang efektif dalam keperawatan (Mtiraoui et al., 2025). Memperoleh kepercayaan diri ini membutuhkan waktu. Namun, mahasiswa keperawatan dapat mengambil sejumlah tindakan untuk mulai membangunnya sebelum mereka mulai bekerja. Untuk memulai, mahasiswa keperawatan dapat berlatih pendelegasian selama proses pembelajaran.

Misalnya, mahasiswa keperawatan dapat menjadi sukarelawan untuk memimpin saat tugas kelompok diberikan. Mereka dapat mengajukan

pertanyaan yang bersifat menyelidiki tentang pendelegasian tugas yang tepat untuk meningkatkan pemahaman mereka dan, pada gilirannya, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Mereka juga dapat mensimulasikan pendelegasian tugas dengan rekan-rekan mereka selama pengalaman klinis.

E. Panduan Komprehensif Manajemen Waktu yang Efektif

Dalam sudut pandang perawatan yang terus berkembang, perawat terus-menerus dihadapkan dengan berbagai tanggung jawab, sembari berusaha keras untuk memberikan tingkat perawatan yang terbaik kepada pasien. Inti dari keberhasilan dalam lingkungan yang menuntut ini adalah penguasaan manajemen waktu – keterampilan yang memberdayakan perawat untuk dengan cekatan menavigasi jaringan tugas rumit yang melekat pada peran mereka (Davies et al., 2019). Mari kita mulai eksplorasi mendalam, dengan mengambil dari berbagai perspektif untuk menjelaskan panduan komprehensif tentang manajemen waktu yang efektif bagi perawat (G. Wilson, 2009):

1. **Buat Jadwal Terstruktur:** Membuat dan memelihara jadwal terstruktur merupakan praktik penting bagi perawat, yang menawarkan mereka kerangka kerja yang kuat untuk mengalokasikan waktu dengan bijaksana dan mempertahankan koherensi alur kerja. Melalui pembagian tugas yang cermat menjadi segmen-segmen yang dapat dikelola, perawat memperoleh ketangkasan untuk beradaptasi dengan gangguan yang tidak terduga tanpa mengorbankan produktivitas. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pemanfaatan waktu yang optimal tetapi juga memungkinkan perawat untuk menangani kebutuhan pasien yang muncul dengan lancar, memastikan bahwa pemberian perawatan tetap responsif dan efisien setiap saat.
2. **Prioritaskan dengan Tepat:** Penetapan prioritas menjadi dasar manajemen waktu yang efektif, yang memandu perawat untuk membedakan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Proses ini melibatkan penggunaan alat seperti kisi prioritas atau daftar tugas yang komprehensif untuk mengatur tanggung jawab secara sistematis. Dengan mengkategorikan tugas, perawat memastikan bahwa aktivitas kritis ditangani dengan segera, menjaga keselamatan dan kesejahteraan pasien. Melalui penentuan prioritas yang tepat, perawat mengoptimalkan alur kerja mereka, memastikan bahwa tugas-tugas penting menerima perhatian yang mereka butuhkan tanpa penundaan (Manalu, 2023).
3. **Delegasikan dengan Bijaksana:** Pendelegasian muncul sebagai pendekatan strategis untuk mengoptimalkan beban kerja, yang memungkinkan perawat untuk mendistribusikan tugas secara efisien di antara anggota tim. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang sesuai untuk didelegasikan, perawat dapat

memanfaatkan keahlian asisten perawat atau penyedia layanan kesehatan khusus (Manalu, Andrianti, et al., 2021). Praktik ini tidak hanya membebaskan waktu bagi perawat untuk fokus pada tanggung jawab kritis tetapi juga meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam memberikan perawatan pasien yang komprehensif. Melalui pendelegasian yang bijaksana, perawat memupuk lingkungan yang kolaboratif sambil memaksimalkan efektivitas pemberian perawatan mereka.

4. **Manfaatkan Teknik Hemat Waktu:** Strategi hemat waktu yang inovatif berperan penting dalam merampingkan proses alur kerja bagi perawat. Ini termasuk mengelompokkan tugas-tugas serupa bersama-sama untuk meminimalkan transisi dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, merangkul prosedur standar dan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti catatan kesehatan elektronik (EHR) mempercepat proses dokumentasi, meminimalkan kesalahan, dan memaksimalkan produktivitas (Cochran et al., 2018). Dengan mengeksplorasi berbagai teknik penghematan waktu, perawat mengoptimalkan alur kerja mereka, memastikan bahwa mereka mengalokasikan waktu mereka secara efektif untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien mereka.
5. **Minimalkan Gangguan:** Mempertahankan fokus di tengah segudang tanggung jawab sangat penting bagi perawat untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian tugas. Perawat dapat meminimalkan gangguan dengan membatasi komunikasi pribadi selama jam kerja dan mengalokasikan waktu khusus untuk tugas-tugas administratif. Memanfaatkan ruang yang tenang untuk dokumentasi lebih mengoptimalkan konsentrasi dan mengurangi kesalahan (Miller et al., 2010). Dengan meminimalkan gangguan, perawat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pekerjaan yang terfokus, memastikan bahwa mereka dapat memberikan perawatan dengan presisi dan perhatian terhadap detail.
6. **Terapkan Istirahat dan Perawatan Diri:** Mengenali pentingnya perawatan diri sangat penting bagi perawat untuk mempertahankan kinerja yang optimal dan mencegah kelelahan. Menyertakan waktu istirahat rutin selama shift dan memprioritaskan aktivitas perawatan diri pada hari libur dapat menumbuhkan kesejahteraan, ketahanan, dan keterlibatan yang berkelanjutan (Manalu, Masruroh, et al., 2021). Dengan memelihara kesehatan fisik dan mental mereka sendiri, perawat memastikan bahwa mereka dapat memberikan perawatan yang penuh kasih secara konsisten, mempertahankan kapasitas mereka untuk memenuhi tuntutan profesi mereka dengan semangat dan kasih sayang.
7. **Membina Jaringan Pendukung:** Membina jaringan pendukung yang terdiri dari rekan sejawat, mentor, dan anggota tim interdisipliner sangat berharga bagi perawat yang ingin mengoptimalkan strategi manajemen waktu mereka.

Jaringan ini memberikan kesempatan untuk bertukar pengetahuan, mencari bimbingan, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemahiran manajemen waktu (Clarke et al., 2025). Dengan memanfaatkan keahlian kolektif dalam lingkungan yang mendukung, perawat memfasilitasi pembelajaran dan inovasi berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas mereka dalam mengelola waktu di tengah tuntutan peran mereka.

8. Mencari Solusi Teknologi: Integrasi teknologi ke dalam praktik keperawatan menawarkan peluang signifikan untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan kemampuan manajemen waktu (Manalu et al., 2022). Aplikasi pelacakan waktu, perangkat digital, dan platform perangkat lunak memfasilitasi penjadwalan, prioritas tugas, dan komunikasi yang efisien dalam tim layanan kesehatan. Dengan memanfaatkan solusi teknologi ini, perawat mengoptimalkan proses dokumentasi dan mendorong koordinasi yang lancar, memastikan bahwa mereka dapat mengalokasikan waktu secara efektif untuk memberikan perawatan pasien yang optimal.
9. Datanglah dengan Persiapan dan Tetap Fleksibel: Pendekatan proaktif terhadap manajemen waktu dimulai dengan datang lebih awal untuk shift, yang memungkinkan perawat untuk mempersiapkan diri secara memadai dan mengantisipasi tantangan potensial. Hal ini menumbuhkan pola pikir proaktif yang memungkinkan perawat beradaptasi dengan lancar terhadap keadaan yang tidak terduga sambil tetap fokus pada tanggung jawab inti (Manalu et al., 2020). Dengan tetap fleksibel, perawat memastikan pemberian perawatan pasien yang optimal, menanggapi situasi yang dinamis secara efektif sambil menjaga integritas alur kerja mereka.

F. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Manajemen Waktu

Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi manajemen waktu di keperawatan sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek (Taylor & Damewood, 1992). Berikut adalah beberapa poin penting mengenai bagaimana teknologi berkontribusi dalam hal ini (Manalu et al., 2022):

1. Sistem Electronic Medical Record (EMR): Penggunaan EMR memungkinkan perawat untuk mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencarian data dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan, sehingga perawat dapat lebih fokus pada perawatan pasien.
2. Otomatisasi Proses Administratif: Teknologi informasi kesehatan memungkinkan otomatisasi berbagai tugas administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan demikian, beban kerja administratif berkurang, memberi lebih

banyak waktu bagi perawat untuk memberikan perawatan langsung kepada pasien.

3. Akses Jarak Jauh dan Telemedicine: Teknologi memungkinkan akses perawatan jarak jauh melalui telemedicine, yang sangat membantu pasien di daerah terpencil atau dengan mobilitas terbatas. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan tetapi juga menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk perjalanan ke fasilitas kesehatan.
4. Penggunaan Aplikasi Kesehatan: Berbagai aplikasi kesehatan yang tersedia membantu perawat dalam merencanakan dan memantau asuhan keperawatan. Aplikasi ini dapat memberikan pengingat untuk pengobatan, memantau kondisi pasien, dan mengelola data kesehatan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan Komunikasi: Teknologi mempermudah komunikasi antara perawat dan pasien serta antar anggota tim medis. Dengan platform komunikasi yang efisien, informasi dapat disampaikan dengan cepat, memungkinkan keputusan klinis yang lebih baik dan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan pasien (Manalu et al., 2020).
6. Analisis Data: Teknologi juga memungkinkan analisis data yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Dengan analisis data yang tepat, perawat dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam kesehatan pasien, yang dapat meningkatkan kualitas perawatan (Bhullar et al., 2021; Taylor & Damewood, 1992).

Secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam keperawatan tidak hanya meningkatkan efisiensi manajemen waktu tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

G. 8 Tips Manajemen Waktu Perawat

Tips manajemen waktu berikut untuk perawat berfungsi sebagai titik awal yang sangat baik bagi setiap perawat yang siap mengambil pendekatan proaktif untuk meningkatkan pengalaman mereka dalam pekerjaan (Manalu, Mukhoirotin, et al., 2021):

1. Prioritaskan Tugas dengan Daftar Tugas

Perawat berinteraksi dengan sejumlah besar informasi selama shift mereka. Mereka juga memiliki banyak tugas untuk dilacak. Mencoba menyimpan semuanya melalui hafalan belaka dapat membuat perawat lelah. Dengan membuat catatan, membuat daftar tugas yang memprioritaskan item menurut urgensi, dan menandai kepada siapa setiap tugas dapat didelegasikan, perawat

mengosongkan ruang dalam pikiran mereka dan meringankan beban mental mereka. Ini dapat meningkatkan ketangkasan mental mereka.

Daftar tugas memungkinkan perawat untuk mengingat detail yang mungkin mereka lupakan. Rincian ini dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai intervensi dan perawatan yang akan mereka putuskan untuk digunakan dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam perawatan pasien sebagai hasilnya. Saat menulis daftar tugas, perawat dapat mengajukan serangkaian pertanyaan kepada diri mereka sendiri untuk membantu mereka memprioritaskan jadwal mereka, seperti:

- a. Apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu dan mengapa?
- b. Apa yang paling dibutuhkan pasien?
- c. Jika ini tidak dilakukan sekarang, apa hal terburuk yang dapat terjadi?

2. Perawatan Klaster

Perawat mengelompokkan perawatan pasien dengan menyelesaikan serangkaian tugas penting dalam satu kunjungan. Jadi, daripada berhenti satu per satu untuk memeriksa tanda-tanda vital pasien, membantu mereka ke toilet, dan memberikan obat, perawat mengurus semua hal ini sekaligus (Manalu, Mukhoirotin, et al., 2021).

Dengan mengelompokkan perawatan, perawat dapat menghindari gerakan maju mundur yang tidak perlu dan, pada gilirannya, menghemat waktu. Hal ini juga menghasilkan lebih sedikit gangguan bagi pasien, yang dapat membantu mereka beristirahat dengan lebih baik.

Penelitian telah menunjukkan bahwa karena perawatan berkelompok membatasi seberapa sering perawat keluar masuk kamar pasien, kebiasaan ini juga dapat menurunkan risiko perawat tertular penyakit menular (Cochran et al., 2018; Davies et al., 2019). Selain menjaga perawat lebih aman, perawatan berkelompok juga dapat menjaga pasien lebih aman. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa, dalam kasus tertentu, perawatan berkelompok dapat mengurangi risiko pasien tertular infeksi saluran kemih dan memperpendek jangka waktu mereka memerlukan kateter urin.

3. Bertindak Proaktif

Peristiwa dan kemunduran yang tidak terduga cenderung terjadi secara teratur dalam keperawatan. Oleh karena itu, perawat perlu mencoba dan tetap selangkah lebih maju dari potensi masalah dengan bertindak proaktif untuk melindungi keselamatan pasien. Keperawatan proaktif berarti mengambil kendali atas situasi, sehingga pasien menerima perawatan yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya (P. D. Wilson et al., 2013). Ini juga

berarti memanfaatkan peluang saat muncul, dan mengantisipasi apa yang mungkin salah.

Misalnya, saat pekerjaan melambat, perawat dapat menggunakan waktu ini untuk menangani tugas-tugas dengan prioritas rendah dan, dengan cara ini, membantu menciptakan penyangga jika kejadian tak terduga terjadi. Atau seorang perawat yang menduga pasien memerlukan tes diagnostik tertentu, seperti rontgen dada, dapat mengundang dokter untuk melakukan evaluasi di ruang triase unit gawat darurat untuk mempercepat perawatan.

Pendekatan proaktif dapat menjadi teknik manajemen waktu perawat yang penting, yang menghasilkan lebih sedikit pekerjaan bagi perawat karena membantu membatasi komplikasi yang mungkin terjadi pada kondisi pasien. Pendekatan ini juga dapat mempercepat penanganan komplikasi, yang dapat mencegah terbentuknya kemacetan yang mungkin memerlukan pengaturan ulang pasien dan menciptakan lebih banyak penundaan dalam pemberian perawatan.

4. Gunakan Pengorganisasian yang Efektif

Pengorganisasian yang efektif dapat membantu perawat memperoleh lebih banyak kendali atas cara mereka menghabiskan hari. Dengan mengatur ruang kerja dan menetapkan rutinitas yang menciptakan keteraturan dan memaksakan struktur logis tentang cara menyelesaikan tugas, perawat dapat bekerja jauh lebih efisien. Efisiensi ini dapat meningkatkan waktu yang dimiliki perawat untuk berinteraksi dengan pasien.

Bersikap terorganisasi juga dapat memberi perawat visibilitas yang lebih baik dalam hal melihat gambaran besar tentang kondisi dan kebutuhan pasien. Visibilitas ini dapat membantu perawat membuat keputusan klinis yang lebih cermat yang menghasilkan hasil pasien yang lebih baik. Strategi organisasi yang bermanfaat dapat mencakup:

- a. Mengembangkan sistem penyimpanan catatan dan dokumen pasien sehingga waktu tidak terbuang sia-sia untuk mencoba menemukan informasi penting
- b. Memulai shift dengan mengelompokkan tugas berdasarkan urgensi, sehingga lebih mudah untuk memprioritaskan dan mengelompokkan perawatan untuk setiap pasien
- c. Menerapkan rutinitas yang memastikan obat-obatan, perlengkapan, dan peralatan yang diperlukan siap dan dapat diakses dengan cepat

Selain itu, pada awal setiap shift, perawat dapat mengatur pekerjaan mereka dengan mempertimbangkan waktu dengan mempertimbangkan

pertanyaan-pertanyaan seperti: Intervensi keperawatan apa yang dapat diterapkan saat menunggu perintah medis?

Sumber daya apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan hari itu yang dapat meningkatkan efisiensi?

5. Lakukan Ronde Per Jam

Kunjungan pasien per jam yang direncanakan membantu perawat memastikan pasien mereka aman, perawatan rutin yang dibutuhkan setiap pasien telah dilakukan, dan kenyamanan setiap pasien telah diperiksa (Malmir & Azizzadeh, 2013). Sebagai praktik terbaik dalam keperawatan, ronde per jam membantu perawat mengendalikan waktu mereka dengan memenuhi kebutuhan pasien terlebih dahulu.

Kiat manajemen waktu untuk perawat ini mengurangi frekuensi pasien menelepon untuk meminta bantuan dan mengurangi pasien jatuh (Mandias et al., 2021). Saat melakukan ronde per jam pada shift siang dan malam, perawat yang mengingat lima hal berikut akan memperoleh manfaat penghematan waktu paling banyak dari praktik tersebut. Masalah yang perlu ditangani dan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan saat melakukan ronde per jam meliputi:

a. Nyeri

Apakah pasien mengalami nyeri? Jika ya, pada tingkat apa? Perawat dapat membahas pilihan untuk mengatasi nyeri tersebut. Mereka dapat menegaskan kembali niat mereka untuk membuat pasien nyaman mungkin.

b. Pispot

Apakah pasien memerlukan bantuan untuk menggunakan kamar mandi? Perawat dapat meyakinkan pasien bahwa kebutuhan kamar mandi mereka adalah prioritas dan bahwa mereka dapat memperoleh bantuan apa pun yang mereka butuhkan.

c. Posisi

Apakah pasien dalam posisi yang nyaman? Perawat mungkin perlu mengubah posisi pasien untuk melindungi kulit mereka. Ini mungkin melibatkan menarik mereka ke atas, meletakkan bantal di bawah anggota tubuh mereka, atau menyesuaikan posisi tempat tidur ke atas atau ke bawah.

d. Barang Pribadi

Dapatkah pasien meraih berbagai barang pribadi mereka, seperti ponsel, pelembap bibir, atau air? Perawat dapat bertanya kepada pasien apakah mereka memiliki semua yang mereka butuhkan dan menawarkan untuk meletakkan barang tertentu lebih dekat.

e. Privasi

Apakah pasien memiliki privasi yang mereka inginkan? Perawat dapat bertanya kepada pasien apakah mereka ingin tirai ditutup, pintu ditutup, dan sebagainya. Mereka juga dapat menegaskan kembali keinginan mereka untuk menghormati kebutuhan privasi pasien.

6. Cari Bantuan

Rekan satu tim sering kali dapat memberikan dukungan yang membantu perawat memperkuat keterampilan manajemen waktu mereka. Berbicara dengan rekan kerja tentang pendekatan mereka terhadap berbagai tugas dapat memungkinkan perawat untuk mempelajari teknik dan proses baru yang meningkatkan efisiensi mereka dan menghilangkan redundansi. Selain itu, meminta rekan kerja untuk memberikan umpan balik yang membangun juga dapat memberi perawat wawasan yang berguna tentang di mana mereka dapat meningkatkan manajemen tugas tertentu.

7. Gunakan Teknologi Secara Efisien

Perawat memiliki berbagai macam alat teknologi untuk membantu mereka memprioritaskan pekerjaan, tetap teratur, meningkatkan produktivitas, melacak kebiasaan, dan masih banyak lagi. Bagi banyak perawat yang sibuk, teknologi berfungsi sebagai cara yang hebat untuk mengelola waktu. Untuk memulai, aplikasi manajemen waktu perawat dapat membantu perawat merencanakan hari-hari mereka, membuat daftar tugas, mengatur pengingat, dan banyak lagi. Aplikasi ini memungkinkan perawat untuk melacak berbagai tugas perawatan pasien dan mencegah kelalaian yang menghabiskan waktu.

Selain itu, banyak organisasi perawatan kesehatan menggunakan perangkat lunak untuk mencatat data pasien. Program-program ini sering kali memiliki fitur pelacakan waktu yang dapat membantu perawat menilai bagaimana mereka menghabiskan waktu dan membuat perubahan seperlunya.

Selain aplikasi manajemen waktu, perawat dapat memanfaatkan aplikasi yang secara khusus melayani komunitas perawatan kesehatan. Beberapa aplikasi ini menyediakan informasi medis, termasuk efek samping obat-obatan tertentu hingga interaksi obat (Manalu et al., 2022). Aplikasi lainnya menyampaikan berita medis terkini, menerjemahkan istilah medis ke berbagai bahasa, dan memberikan deskripsi penyakit dan gejalanya. Menggunakan alat-alat ini dapat memberdayakan perawat untuk berkomunikasi dengan populasi pasien yang beragam, memverifikasi informasi, mendidik pasien dengan lebih baik, dan mengembangkan kebiasaan menghemat waktu.

8. Istirahat penting bagi perawat

Meskipun mungkin berlawanan dengan intuisi, beristirahat sebenarnya dapat membantu perawat menghemat waktu. Sementara beberapa perawat memilih untuk melewatkan makan siang dan bahkan tidak mengambil waktu istirahat sebentar dari tugas mereka, hal ini terkadang dapat lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat (G. Wilson, 2009).

Mengambil waktu untuk beristirahat sesekali dapat menurunkan risiko perawat mengalami cedera saat bekerja dan melakukan kesalahan. Istirahat juga dapat membantu mengurangi kelelahan dan kejenuhan (Jainurakhma et al., 2021; Katuuk et al., 2020; Levy, 1982). Tanpa kesempatan untuk pulih dan bersantai, perawat mungkin kesulitan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Selain itu, kejenuhan perawat tidak hanya membahayakan kesejahteraan dan moral perawat secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi terhadap kekurangan perawat saat ini.

Beberapa kiat untuk beristirahat yang dapat membantu perawat merasa berenergi kembali: makan camilan sehat, jalan-jalan di luar, bermeditasi, terlibat dalam percakapan yang tidak terkait dengan pekerjaan dengan rekan kerja, dan mendengarkan musik.

H. Kesimpulan

Kesimpulannya, manajemen waktu yang efektif berfungsi sebagai landasan bagi perawat untuk menavigasi kompleksitas peran mereka dan memberikan perawatan pasien berkualitas tinggi secara konsisten. Dengan memadukan penjadwalan terstruktur, teknik penentuan prioritas, strategi pendelegasian, teknik penghematan waktu, praktik konsentrasi, kebiasaan perawatan diri, jaringan pendukung, solusi teknologi, dan fleksibilitas proaktif ke dalam alur kerja mereka, perawat dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam mengelola waktu di tengah tuntutan lingkungan layanan kesehatan. Pada akhirnya, menguasai manajemen waktu memberdayakan perawat untuk berkembang secara profesional sambil menegaskan standar tertinggi perawatan yang berpusat pada pasien.

I. Referensi

- Bhullar, H., County, B., Barnard, S., Anderson, A., & Seddon, M. E. (2021). Reducing the MRI outpatient waiting list through a capacity and demand time series improvement programme. *New Zealand Medical Journal*, 134(1537), 27–35.
- Clarke, J., Davis, K., Douglas, J., & Peters, M. D. J. (2025). Defining nurse-led models of care: Contemporary approaches to nursing. *International Nursing*

- Review*, 72(1). <https://doi.org/10.1111/inr.13076>
- Cochran, D., Swartz, J., Elahi, B., & Smith, J. (2018). Using the Collective System Design Methodology to Improve a Medical Center Emergency Room Performance. *Journal of Medical Systems*, 42(12). <https://doi.org/10.1007/s10916-018-1102-7>
- Davies, C., Lyons, C., & Whyte, R. (2019). Optimizing nursing time in a day care unit: Quality improvement using Lean Six Sigma methodology. *International Journal for Quality in Health Care: Journal of the International Society for Quality in Health Care*, 31(1), 22–28. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzz087>
- Dolu, I., & Nahcivan, N. O. (2019). Impact of a nurse-led sleep programme on the sleep quality and depressive symptomatology among older adults in nursing homes: A non-randomised controlled study. *International Journal of Older People Nursing*, 14(1). <https://doi.org/10.1111/opn.12215>
- Foy, J. M., & Earls, M. F. (2005). A process for developing community consensus regarding the diagnosis and management of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, 115(1). <https://doi.org/10.1542/peds.2004-0953>
- Jainurakhma, J., Damayanti, D., Manalu, N. V., Supriadi, E., Sinaga, R., Meinarisa, Widodo, D., Suwanto, T., Sihombing, R. M., Saputra, B. A., Setyarini, A., Mariyana, R., Malisa, N., & Rantung, G. A. (2021). *CARING: PERAWAT GAWAT DARURAT* (R. Watrianthos (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Katuuk, M. E., Sitorus, R., & Sukmarini, L. (2020). PENERAPAN TEORI SELF CARE OREM DALAM ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DIABETES MELITUS. *JURNAL KEPERAWATAN*, 8(1). <https://doi.org/10.35790/jkp.v8i1.28405>
- Kim, K. H., & Shin, S. (2025). Factors influencing preceptor nurses' clinical teaching behavior: A cross-sectional study. *Nurse Education Today*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106555>
- Laing, D., & Smythe, A. (2025). The challenges and needs of international nurses who are assimilating to healthcare systems in the United Kingdom: Experience from the field. *International Nursing Review*, 72(1). <https://doi.org/10.1111/inr.13078>
- Levy, G. (1982). Gastrointestinal Clearance of Drugs with Activated Charcoal. *New England Journal of Medicine*, 307(11). <https://doi.org/10.1056/nejm198209093071109>
- Love, R. A., Murphy, J. A., Lietz, T. E., & Jordan, K. S. (2012). The effectiveness of a provider in triage in the emergency department: A quality improvement initiative to improve patient flow. *Advanced Emergency Nursing Journal*, 34(1), 65–74. <https://doi.org/10.1097/TME.0b013e3182435543>
- Malmir, A., & Azizzadeh, F. (2013). Evaluation of Self-leadership Statue and

- Providing Solutions to Improve the Self-leadership Statue (Payam Noor University- Kermanshah Branch Case Study). *International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies*, 4(1). <https://doi.org/10.5121/ijmpict.2013.4101>
- Manalu, N. V. (2023). *Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan* (N. Rismawati (ed.); 1st ed., Vol. 16, Issue 1). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Manalu, N. V., Andrianti, S., Syarif, H., Martini, S., Yunike, Pebrianti, D., Kusumawaty, I., Farani, S., Demang, F. Y., Rozi, V. F., Hutapea, D., Fitriani, R. J., & Jakri, Y. (2021). *Ilmu Keperawatan Umum dan Kesehatan Masyarakat* (A. Munandar (ed.); 1st ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Manalu, N. V., Masruroh, Manramis, J. R., Mardiana, S. S., Ulfa, A. F., Suwanto, T., Praghlapati, A., Muniroh, S., Esther, L. D. M., Sihombing, R. M., & Kurniawati. (2021). *Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Keperawatan* (R. Watrionthos (ed.); 1st ed., pp. 69–109). Yayasan Kita Menulis.
- Manalu, N. V., Mukhoirotin, Esther, L. D. ., Purnawinadi, I. G., Widodo, D., Sihombing, R. M., Suwanto, T., & Praghlapati, A. (2021). *Keperawatan Profesional* (D. . Pratama (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Manalu, N. V., Munandar, A. M., Andini, N. K. S., Hidayat, C. T., Arini, T., Candrawati, S. A. K., Suek, O. D., Rahayu, D. A., Agustini, N. L. P. I. B., Elmagfuroh, D. R., Oktaviani, E., Haryanti, D. Y., Hamu, A. H., Nursery, S. M. C., Widada, W., Chrismilasari, L. A., Ernawati, Werdani, Y. D. W., Diana, V., ... Dewi, S. R. (2020). *Keperawatan Paliatif (Konsep dan Penerapan)* (A. Munandar (ed.); 1st ed.). Media Sains Indonesia.
- Manalu, N. V., Rantung, G. A., Yudianto, B. A., Praghlapati, A., Damayanti, D., Manik, M. J., Sinaga, R., Limbong, M., & Perangin-angin, M. A. (2022). *Sistem Informatika Keperawatan* (M. J. Sirait & J. Simarmata (eds.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Mandias, R. J., Simbolon, S., Manalu, N. V., Elon, Y., Jainurakhma, J., Suwanto, T., Latipah, S., Amir, N., & Boyoh, D. (2021). *Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan dalam Keperawatan* (A. Karim (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Miller, K., Rodger, S., Bucolo, S., Greer, R., & Kimble, R. M. (2010). Multi-modal distraction. Using technology to combat pain in young children with burn injuries. *Burns*, 36(5), 647–658. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2009.06.199>
- Mtiraoui, A., Mahjoubi, H., Achour, A., Ghardallou, M., & Nakhli, J. (2025). The Impact of Psychological First Aid Training (RAPID-PFA) on Self-Efficacy, Perceived Competencies and Disaster Preparedness of Nursing Students in Tunisian Public Institutions: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 33(1).

<https://doi.org/10.1111/1468-5973.70019>

- O'mahony, L., McCarthy, K., O'donoghue, J., Teeling, S. P., Ward, M., & McNamara, M. (2021). Using lean six sigma to redesign the supply chain to the operating room department of a private hospital to reduce associated costs and release nursing time to care. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph182111011>
- Soliman, F. (1997). Improving resource utilization through patient dependency systems. *Journal of Medical Systems*, 21(5), 291–302. <https://doi.org/10.1023/A:1022820624783>
- Taylor, J. W., & Damewood, E. Z. (1992). Using the operations management modeling technique of linear programming to determine optimal case mix of three cardiac services. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation*, 12(6), 407–412. <https://doi.org/10.1097/00008483-199211000-00006>
- Wilson, G. (2009). Implementation of releasing time to care - The productive ward. *Journal of Nursing Management*, 17(5), 647–654. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2009.01026.x>
- Wilson, P. D., Hutchings, A., Jeans, A., & Macdougall, I. C. (2013). An analysis of the health service efficiency and patient experience with two different intravenous iron preparations in a UK anaemia clinic. *Journal of Medical Economics*, 16(1), 108–114. <https://doi.org/10.3111/13696998.2012.731458>

J. Glosarium

NCBN : *The National Council of State Boards of Nursing*

PROFIL PENULIS



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep., Penulis yang akrab dipanggil Willy ini lahir di Malaka-NTT, 27 Mei 1972. Memiliki Riwayat Pendidikan: Akper PEMDA Kupang, tamat tahun 1996, Ners Unair tamat tahun 2004, S2 Keperawatan Unair, tamat tahun 2010, S3 Keperawatan UI, tamat tahun 2023. Penulis sebagai staf dosen tetap pada program studi PPN Poltekkes Kemenkes Kupang. Riwayat organisasi: sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi NTT, Anggota Bidang Diklat DPP PPNI, Anggota Bidang V Kolegium Keperawatan Indonesia.

Email Penulis: aemilianusmau58@gmail.com



Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua., Lahir di Sragen, 22 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKPER Telogorejo Semarang lulus tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2006, Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2018, S2 Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang lulus tahun 2008, S2 Magister Keperawatan Universitas Karya Husada (UNKAHA) Semarang lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di SMC RS. Telogorejo Semarang. Saat ini penulis bekerja di Stikes Telogorejo Semarang mengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah Satu Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Surveior Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN). Penulis aktif dalam Organisasi : Himpunan Perawat Manager Indonesia (HPMI), Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN), Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (HIPPII). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dapat dihubungi melalui e-mail: rusminippi@gmail.com

Motto: *"Living your life well", "Focus on goals, not obstacles"*

PROFIL PENULIS



Ns. Eliza, S.Pd., S.Kep., M.Kep., lahir di Padang, 30 Juni 1972. Menempuh Pendidikan Diploma III Keperawatan di Akper Perintis Bukittinggi Tahun Lulus 1994, Pendidikan S1 Pendidikan di Universitas Negeri Padang Lulus Tahun 2004, selanjutnya Pendidikan S1 Keperawatan di STIKes Nan Tongga Lubuk Alung lulus Tahun 2011, menempuh Profesi Ners di STIKes Nan Tongga lulus tahun 2012. Dan melanjutkan Pendidikan S2 Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang lulus tahun 2018. Mengawali penulis menjadi dosen tahun 1996 di Akper Nan Tongga Pariaman. Saat ini Aktif sebagai Dosen di Universitas Syedza Saintika

Padang sejak tahun 2022 sampai sekarang dan sebelumnya pernah menjadi dosen di STIKes Nan Tongga Lubuk Alung dari tahun 1996 dan berubah bentuk tahun 2021 menjadi Universitas Sumatera Barat dan STIKes Amanah Padang Tahun 2013 – 2016 t. Buku Pertama penulis berjudul Praktik Laboratorium Keperawatan Maternitas tahun 2022, Buku Ajar Prosedur Tindakan Keperawatan Dasar Tahun 2023, Buku Nursing Manajemen Tahun 2023, Buku Ensiklopedia Infeksi Penyakit Menular Tahun 2023. Buku Manajemen Sumber Daya Kesehatan di Masa Krisis Tahun 2024. Dalam bidang organisasi saat ini penulis aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan di DPD PPNI Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai Pengurus Himpunan Perawat Manejer Indonesia (HPMI) Provinsi Sumatera Barat. Kontak Email : elizaeliza7251@gmail.com

Motto: ***"There are no shortcuts to success, only effort and hard work"***



Novita Verayanti Manalu, S.Kp., Ns., MAN., Lahir di Palembang, 03 November 1977, menyelesaikan Pendidikan D3 Keperawatan tahun 1999 dan S1 keperawatan tahun 2001 dari UNAI, dan S2 Keperawatan tahun 2009 dari Philippine Women's University. Saat ini sedang dalam penyelesaian disertasi S3 Keperawatan di Universitas Airlangga. Pengalaman bekerja sebagai staf Instalasi Gawat Darurat RS. Advent Bandung (2001-2003), lalu menjadi Dosen FIK Universitas Advent

Indonesia Bandung hingga saat ini. Penulis aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, seminar dan publikasi nasional dan internasional. Penulis aktif menjadi Pengurus DPW *Indonesian Wound Ostomy Continence* PPNI Lampung. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: verayantimanalu@unai.edu

Buku *Manajemen Kualitas dan Peningkatan Layanan Keperawatan* merupakan panduan komprehensif bagi para tenaga keperawatan, pendidik, dan manajer layanan kesehatan yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam praktik keperawatan sehari-hari. Disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, buku ini mengintegrasikan konsep teoritis dengan pendekatan praktis yang relevan dengan dinamika pelayanan kesehatan masa kini.

Lima bab utama dalam buku ini membahas secara mendalam topik-topik kunci yang mendukung peningkatan kualitas layanan keperawatan. Dimulai dari pentingnya Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi perawat sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi individu, hingga strategi Audit Keperawatan yang efektif untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan.

Pembaca juga akan diajak memahami pentingnya Pengelolaan Risiko dalam mencegah insiden serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu, buku ini mengupas bagaimana Pemanfaatan Teknologi dapat menjadi katalisator transformasi layanan keperawatan yang lebih responsif dan efisien. Ditutup dengan pembahasan mengenai Manajemen Waktu, buku ini memberikan teknik dan tips praktis agar perawat mampu mengelola beban kerja secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Dengan gaya penulisan yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran maupun praktik di lapangan, serta sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan budaya mutu dalam layanan keperawatan.

Buku Manajemen Kualitas dan Peningkatan Layanan Keperawatan merupakan panduan komprehensif bagi para tenaga keperawatan, pendidik, dan manajer layanan kesehatan yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam praktik keperawatan sehari-hari. Disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, buku ini mengintegrasikan konsep teoritis dengan pendekatan praktis yang relevan dengan dinamika pelayanan kesehatan masa kini.

Lima bab utama dalam buku ini membahas secara mendalam topik-topik kunci yang mendukung peningkatan kualitas layanan keperawatan. Dimulai dari pentingnya Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi perawat sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi individu, hingga strategi Audit Keperawatan yang efektif untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan.

Pembaca juga akan diajak memahami pentingnya Pengelolaan Risiko dalam mencegah insiden serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu, buku ini mengupas bagaimana Pemanfaatan Teknologi dapat menjadi katalisator transformasi layanan keperawatan yang lebih responsif dan efisien. Ditutup dengan pembahasan mengenai Manajemen Waktu, buku ini memberikan teknik dan tips praktis agar perawat mampu mengelola beban kerja secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Dengan gaya penulisan yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran maupun praktik di lapangan, serta sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan budaya mutu dalam layanan keperawatan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-11-4



9

786347

219114